

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

**TÜRKİYE’DE GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBA
DUYULAN GÜVENİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ**

Lisans Bitirme Tezi

Hazırlayan

Yade İrem BİLGİÇ

20221101063

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇOKER

İSTANBUL, HAZİRAN 2026

ÖZET

TÜRKİYE’DE GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBA DUYULAN GÜVENİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

Bu çalışmada, Wellcome Global Monitor (WGM) 2018 veri setinin Türkiye örnekleminde süzülen 790 katılımcı üzerinden, yetişkinlerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) şifacılarına yönelik güven düzeyleri ile sosyo-demografik özellikleri ve sağlık tutumları arasındaki çok boyutlu ilişkiler incelenmiştir. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, Ki-Kare bağımsızlık testi, standart varyans şışmelerini arındıran Düzeltilmiş Burt Matrisi tabanlı Çoklu Uyum Analizi (MCA) ve Çok Terimli Lojistik Regresyon Analizi uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, katılımcıların %60,5’inin şifacılarına yönelik "sınırlı" düzeyde, temkinli bir güven sergilediği saptanmıştır. Çok Terimli Lojistik Regresyon modeli sonuçlarında; yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, yerleşim yeri ve aşıllara yönelik tutum değişkenlerinin şifacılara tam güven duyma olasılığı üzerinde doğrudan bir ana etkisi tespit edilememiştir. Buna karşılık, algılanan gelir düzeyi "yüksek" olan bireylerin, düşük gelirli referans grubuna kıyasla şifacılara yüksek düzeyde güven duyma olasılığının 3,134 kat daha fazla olduğu saptanmıştır. Modelin en güçlü belirleyicisi olarak, doktor ve hemşirelere güveni "yüksek" olan katılımcıların, düşük/sınırlı güven grubuna kıyasla şifacılara yüksek düzeyde güven duyma olasılığının tam 4,707 kat daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak; Türkiye’de şifacılara yönelik güven resmi sağlık sistemine bir reaksiyondan beslenmemekte; aksine hem yüksek ekonomik sermayenin getirdiği bir yaşam tarzı ve tüketim tercihi hem de kurumsal tıp aktörlerine duyulan güvenle paralel ilerleyen bütünleşik bir sağlık arayışı niteliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Şifacılara Güven, Çoklu Uyum Analizi, Çok Terimli Lojistik Regresyon, Wellcome Global Monitor.

ABSTRACT

STATISTICAL ANALYSIS OF TRUST IN TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE IN TURKEY

This study examines the multidimensional relationships between the levels of trust in traditional and complementary medicine (T&CM) healers among adults in Turkey, and the socio-demographic characteristics and health attitudes that shape this perception, utilizing the Turkey sample of the Wellcome Global Monitor (WGM) 2018 dataset (N = 790). In the data analysis process, descriptive statistics, the Chi-square test of independence, Adjusted Burt Matrix-based Multiple Correspondence Analysis (MCA) designed to eliminate artificial variance inflation, and Multinomial Logistic Regression Analysis were applied. According to the empirical findings, 60.5% of the participants exhibited a cautious and "limited" level of trust toward healers. The results of the Multinomial Logistic Regression model indicated that age, gender, education level, residential area, and attitudes toward vaccines had no statistically significant direct or independent main effect on the probability of placing full trust in healers. Conversely, individuals with a "high" perceived income level were found to be 3.134 times more likely to possess a high level of trust in healers compared to the low-income reference group. Serving as the strongest predictor of the model, participants with "high" trust in doctors and nurses were 4.707 times more likely to demonstrate a high level of trust in healers than the low/limited trust group. In conclusion, contrary to prevalent prejudices in the literature, trust in traditional and complementary medicine healers in Turkey does not stem from a reaction to or helplessness regarding the institutional healthcare system. Instead, this trust functions both as a lifestyle and consumption preference driven by higher economic capital (income level) and as an integrated health-seeking behavior running parallel to and integrated with the trust placed in institutional medical actors.

Keywords: Traditional and Complementary Medicine, Trust in Healers, Multiple Correspondence Analysis, Multinomial Logistic Regression, Wellcome Global Monitor.

ÖNSÖZ

Lisans bitirme tezi çalışmasının planlanması, verilerin analizi ve yürütülmesi aşamalarında kıymetli bilgi, birikim ve yönlendirmeleriyle bana yol gösteren, akademik gelişimime büyük katkı sağlayan değerli danışman hocam Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇOKER'e en içten teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde geçirdiğim eğitim hayatım boyunca bana destek olan tüm bölüm hocalarıma, lisans eğitimim süresince maddi ve manevi desteklerini her an arkamda hissettiğim sevgili aileme ve yanımda olan tüm dostlarıma minnettarım.

İÇİNDEKİLER

ÖZET.....	ii
ABSTRACT.....	iii
ÖNSÖZ	iv
ÇİZELGE LİSTESİ.....	vii
ŞEKİL LİSTESİ	viii
SEMBOL VE KISALTMALAR LİSTESİ.....	ix
1. GİRİŞ	1
2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI.....	3
2.1 Modern Tıp Anlayışı ve Tıbbi Çoğulculuk	3
2.2 Türkiye’de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ve Yasal Gelişmeler.....	3
2.3 Sağlık Tutumları, Kurumsal Güven ve Sosyo-Ekonomik Faktörler	4
2.4 Literatürde Geleneksel Tıbbi Güven Üzerine Yapılan Çalışmalar	6
3. MATERYAL VE YÖNTEM.....	8
3.1 Veri Seti ve Örneklem Yapısı	8
3.2 Değişkenler ve Değişkenlerin Tanımlanması/Kodlanması	8
3.3 İstatistiksel Yöntemler ve Analiz Süreci	9
3.3.1 Betimsel İstatistikler	9
3.3.2 Ki-Kare (X^2) Bağımsızlık Testi.....	10
3.3.3 Düzeltilmiş Burt Matrisi Çoklu Uyum Analizi (MCA)	10
3.3.4 Çok Terimli Lojistik Regresyon Analizi	10
3.3.5 Veri Analizinde Kullanılan Paket Programlar	11
4. BULGULAR.....	12
4.1 Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılım.....	13
4.2 Katılımcıların Sağlık Tutum ve Güven Algılarına İlişkin Dağılım	14
4.3 Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Şifacılara Yönelik Güven Düzeylerinin Karşılaştırılması	15
4.4 Katılımcıların Sağlık Tutum ve Güven Algılarına Göre Şifacılara Yönelik Güven Düzeylerinin Karşılaştırılması	16
4.5 Uyum Analizi Yöntemlerine Göre Açıklanan Varyans Oranlarının Karşılaştırılması.....	17
4.6 Düzeltilmiş Burt Matrisi Çoklu Uyum Analizi Sonuçları.....	18
4.7 Katılımcıların Şifacılara Yönelik Güven Düzeylerini Belirleyen Etmenlere İlişkin Lojistik Regresyon Analizi.....	25

5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA	30
5.1 Giriş ve Araştırmanın Genel Değerlendirmesi	30
5.2 Şifacılar Yönelik Güven Algısının Bütünleşik Değerlendirilmesi	30
5.2.1 Algılanan Gelir Düzeyinin Güven Algısı Üzerindeki Etkisi.....	30
5.2.2 Doktor ve Hemşirelere Güven Düzeyinin Güven Algısı Üzerindeki Etkisi	31
5.2.3 Anlamsız Çıkan Faktörlerin Değerlendirilmesi: Demografik Özellikler ve Aşı Tutumu	32
5.3 Güven Algısının Boyutsal ve Geometrik Yapısı.....	33
5.4 Modellerin Yöntemsel Geçerliliği ve Genel Değerlendirme	34
5.5 Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler	35
KAYNAKÇA	36

ÇİZELGE LİSTESİ

Çizelge 4.1 Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılım (N=790)	13
Çizelge 4.2 Katılımcıların Sağlık Tutum ve Güven Algılarına İlişkin Dağılım (N=790)	14
Çizelge 4.3 Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Şifacılaraya Yönelik Güven Düzeylerinin Karşılaştırılması (N=790)	15
Çizelge 4.4 Katılımcıların Sağlık Tutum ve Güven Algılarına Göre Şifacılaraya Yönelik Güven Düzeylerinin Karşılaştırılması (N=790)	16
Çizelge 4.5 Uyum Analizi Yöntemlerine Göre Açıklanan Varyans Oranlarının Karşılaştırılması (N=790)	17
Çizelge 4.6 Katılımcıların Şifacılaraya Yönelik Güven Düzeylerini Belirleyen Etmenlere İlişkin Lojistik Regresyon Analizi (N=790)	26

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 4.1 Katılımcıların Geleneksel ve Tamamlayıcı Şifacılarına Yönelik Güven Düzeyleri	15
Şekil 4.2 Düzeltilmiş Burt Matrisine Ait Yamaç (Scree) Grafiği	19
Şekil 4.3 Değişken Kategorilerinin 1. Boyuta Katkı Payları (%)	20
Şekil 4.4 Değişken Kategorilerinin 2. Boyuta Katkı Payları (%)	21
Şekil 4.5 Düzeltilmiş Burt Matrisi Değişken Kategorileri Faktöriyel Dağılım Haritası (Biplot)	22
Şekil 4.6 Şifacıların Güven Algısına Göre Katılımcı Kümelerinin Dağılımı ve Güven Elipsleri	24

SEMBOL VE KISALTMALAR LİSTESİ

GETAT	Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
WGM	Wellcome Global Monitor
MCA	Çoklu Uyum Analizi (Multiple Correspondence Analysis)
JCA	Ortak Uyum Analizi (Joint Correspondence Analysis)
WHO	Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)
T&CM	Traditional and Complementary Medicine
SPSS	IBM Statistical Package for the Social Sciences
(X²)	Ki-Kare İstatistiksel Değeri
<i>df</i>	Serbestlik Derecesi (Degrees of Freedom)
<i>p</i>	İstatistiksel Anlamlılık Değeri (Significance Value)
<i>B</i>	Regresyon Katsayısı
Exp(<i>B</i>)	Odds Oranı (Göreceli Olasılıklar Oranı)
C.I.	Güven Aralığı (Confidence Interval)
Ref	Referans Kategorisi

1. GİRİŞ

Modern sađlık sosyolojisi literatüründe sađlık ve hastalık, yalnızca biyolojik birer durum olarak deđil, toplumsal yapının ve kültürel süreçlerin birer yansıması olarak ele alınmaktadır. Tarihsel gelişim içinde kurumsallaşan modern tıp (biyotıp) modeli, pozitivist bilim anlayışına dayanarak resmi sađlık sistemlerinin temeli olmuştur. Ancak zamanla ortaya çıkan bazı bürokratik yapılar ve hekim-hasta ilişkisindeki teknikleşme, kurumsal tıba yönelik çeşitli eleştirileri beraberinde getirmiştir. Bu durum modern tıbbın tamamen reddedilmesine yol açmamış; aksine resmi tıp ile geleneksel yöntemlerin bir arada kullanıldığı “tıbbi çoğulculuk” zemininde bütünleşik bir sađlık arayışını doğurmuştur.

Türkiye’nin köklü halk hekimliği mirası da bu küresel eğilimlerle paralel bir dönüşüm geçirmektedir. Özellikle T.C. Sađlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında yürürlüğe konulan yönetmelikle birlikte, geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamaları resmi bir statü kazanarak klinik ortama taşınmıştır. Bu yeni yasal zemin, literatürde yer alan “tepki” ve “tüketim” modelleri çerçevesinde şifacılaraya yönelik güven algısını yeniden tartışmaya açmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye genelini temsil eden bu güven dinamiklerinin kategorik veri analizi teknikleriyle incelenmesi tezin temel odak noktasını oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda tezin temel amacı; Türkiye’deki bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp şifacılarına yönelik güven düzeyleri ile bu algıyı şekillendiren sosyo-demografik özellikleri ve sađlık tutumlarını makro düzeyde belirlemektir. Araştırmada veri materyali olarak, Wellcome Global Monitor (WGM) 2018 veri setinin Türkiye örnekleminde süzülen ve ülke genelini temsil eden N=790 katılımcılık bir veri blođu kullanılmıştır (Wellcome Trust, 2019).

Yöntemsel ve istatistiksel açıdan bu çalışma, dar kitlelere uygulanan kısıtlı yerel araştırmalardan ayrılmaktadır. Araştırma kapsamında; verilerin dağılımını özetleyen betimsel analizler ve iki değişkenli ilişkileri ortaya koyan Ki-Kare testlerinin ardından, değişkenlerin çok boyutlu uzaydaki bağlarını standart matrislerin yarattığı suni varyans şişmelerinden arındırarak görselleştiren Düzeltilmiş Burt Matrisi tabanlı Çoklu Uyum Analizi (MCA) uygulanmıştır. Geometrik olarak saptanan bu ilişki ağırları, diğer tüm sosyo-demografik etmenler kontrol edildiğinde ortaya çıkan bağımsız olasılık oranlarını saptamak amacıyla Çok Terimli Lojistik Regresyon Analizi ile test

edilmiştir (Hosmer ve Lemeshow, 2013). Bu yönüyle çalışma, Türkiye’de bütünleşik sağlık inancının arkasındaki kurumsal ve sosyo-ekonomik dinamikleri ileri kategorik veri analizi teknikleriyle haritalandıran kapsamlı bir ampirik katkı sunmaktadır.

2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI

Sağlık ve hastalık kavramları, salt biyolojik birer olgu olmanın ötesinde, toplumların kültürel, ekonomik ve kurumsal yapılarıyla şekillenen toplumsal süreçlerdir (Cirhinlioğlu, 2010). Bu bölümde; modern tıp sisteminin gelişimi, bu sistemin kurumsal aktörlerine yönelik güven inşası, geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) pratiklerinin yasal ve toplumsal dönüşümü ile bireylerin sağlık tutumlarını şekillendiren sosyo-ekonomik dinamikler literatürdeki teorik tartışmalar çerçevesinde ele alınmaktadır.

2.1 Modern Tıp Anlayışı ve Tıbbi Çoğulculuk

Endüstri devrimi ve modernleşme süreciyle birlikte tıp anlayışı, insan bedenini mekanik bir sistem, hastalıkları ise bu sistemdeki bir arıza olarak gören biyotıp modelinin hakimiyeti altına girmiştir (Cirhinlioğlu, 2010). Biyotıp modeli; standartlaşma, kurumsallaşma, klinik uzmanlaşma ve pozitivist bilim anlayışı üzerinden meşruiyet kazanmış ve resmi sağlık sistemlerinin ana taşıyıcısı olmuştur (Cockerham, 2016). Ancak 20. yüzyılın sonlarından itibaren, modern tıbbın kronik hastalıklar karşısındaki bazı yetersizlikleri, tedavi süreçlerinin aşırı teknikleşerek insan ilişkilerinden uzaklaşması ve hastane odaklı bürokratik yapılar, kurumsal tıp sistemine yönelik çeşitli eleştirileri beraberinde getirmiştir (Turner, 1995).

Bu süreçte bireylerin kurumsal otoritelere olan sarsılmaz inancının yerini daha sorgulayıcı bir sağlık tutumuna bırakması, tıp algısında önemli bir değişim yaratmıştır (Kasapoğlu, 1999). Bu değişim, geleneksel ve modern tıp pratiklerinin bir arada var olduğu tıbbi çoğulculuk kavramını doğurmuştur. Günümüzde bireyler, geleneksel pratikleri modern tıbbın mutlak bir reddi olarak görmemekte; aksine modern tıbbın sunduğu teknolojik imkanlar ile geleneksel yaklaşımların sunduğu bütüncül ve semptomdan ziyade genel iyilik halini önceleyen bakış açısını bir arada kullanmayı tercih etmektedir (Cockerham, 2016).

2.2 Türkiye’de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ve Yasal Gelişmeler

Türkiye’de geleneksel şifacılık ve halk hekimliği pratikleri, kökleri Orta Asya, Selçuklu ve Osmanlı tıbbına uzanan çok katmanlı bir kültürel mirasa sahiptir

(Cirhinlioğlu, 2010). Cumhuriyet'in ilanından sonra modern sağlık sisteminin inşası ve merkezileştirilmesi amacıyla çıkarılan 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile tıp eğitimi almamış kişilerin şifacılık faaliyetleri yasaklanmış ve resmi tıp alanı kesin sınırlarla korunmuştur. Bu süreçte geleneksel şifacılık pratikleri resmi sistemin dışına itilerek yerel unsurlar olarak varlığını sürdürmüştür.

Ancak küresel düzeyde yükselen bütünsel sağlık eğilimleri, Türkiye'deki yasal otoritelerin de bu alana yönelik politikalarda köklü bir değişiklik yapmasına yol açmıştır. Bu doğrultuda en büyük dönüm noktası, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında yürürlüğe konulan "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği" olmuştur (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2014). Bu mevzuat ile akupunktur, fitoterapi, sülük tedavisi ve hacamat gibi birçok geleneksel pratik, Sağlık Bakanlığı onaylı GETAT merkezlerinde ve yalnızca tıp doktorları tarafından uygulanmak şartıyla resmi ve kurumsal bir statüye kavuşturulmuştur.

Bu durum, literatürdeki "şifacı" ve "alternatif tıp" kavramlarının niteliğini de dönüştürmüştür. Artık geleneksel şifacılık, modern tıp sisteminin merdiven altı bir alternatifi değil; bizzat üniversite hastanelerinde klinik ortamda sunulan, devlet eliyle denetlenen ve kurumsal tıp aktörleriyle entegre edilen bütünsel bir yapı haline gelmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2014). Nitekim literatürde tıp doktorları ve sağlık personeli üzerinde yapılan araştırmalar, kurumsal tıp aktörlerinin de yasal düzenlemeler sonrasında GETAT pratiklerine yönelik bilgi, farkındalık ve olumlu tutumlarında belirgin bir artış olduğunu; bu pratiklerin modern tıp eğitimiyle desteklenmesi gerektiğini düşündüklerini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla günümüz Türkiye'sinde şifacılara ve geleneksel tıba yönelik güven algısını incelerken, bu pratiklerin kurumsal sistemle ve tıp profesyonelleriyle olan bu yeni hukuki ve toplumsal bağını dikkate almak gerekir.

2.3 Sağlık Tutumları, Kurumsal Güven ve Sosyo-Ekonomik Faktörler

Sosyolojik literatürde, bireylerin geleneksel ve alternatif tıp yöntemlerine yönelmesini açıklayan iki temel kuramsal yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi "reaksiyon (tepki) modeli", ikincisi ise "entegrasyon (tüketim) modeli" olarak adlandırılmaktadır (Cockerham, 2016).

- **Reaksiyon Modeli:** Bu yaklaşıma göre alternatif tıbbı duyulan güven, kurumsal tıp sistemine, doktorlara ve koruyucu sağlık hizmetlerine (aşılara) duyulan güvensizlikten beslenmektedir (Turner, 1995). Bireyler resmi sağlık sisteminden dışlandıklarını veya zarar gördüklerini düşündüklerinde, bir tepki olarak şifacılar ve resmi olmayan kanallara yönelmektedir.
- **Entegrasyon ve Tüketim Modeli:** Bu model ise geleneksel pratiklere yönelimi kurumsal tıbbı bir tepki olarak değil; bireylerin kendi sağlık süreçleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istedikleri pratik bir yaşam tarzı ve tüketim tercihi olarak ele almaktadır (Cockerham, 2016). Birey, modern tıbbın imkanlarını kullanırken, eş zamanlı olarak geleneksel yöntemleri de onun bir tamamlayıcısı olarak hayatına dahil etmektedir.

Sosyo-ekonomik açıdan bakıldığında, klasik literatür uzun yıllar boyunca geleneksel tıp kullanımını eğitim seviyesi düşük, kırsal kesimde yaşayan ve modern sağlık hizmetlerine erişim gücü olmayan yoksul kesimlerin bir zorunluluk yönelimi olarak tanımlamıştır (Kasapoğlu, 1999). Ancak güncel çalışmalar bu görüşü giderek daha fazla çürütmektedir. Modern dünyada GETAT pratikleri, organik beslenme, sağlıklı yaşam (wellness) ve kişiselleştirilmiş sağlık arayışıyla birleşerek ekonomik sermayesi yüksek sınıfların birer tüketim tercihi haline gelmiştir (Cockerham, 2016). Dolayısıyla yüksek gelir düzeyine sahip olmak, alternatif sağlık hizmetlerini bir yaşam tarzı tercihi olarak satın alabilme gücünü ve bu pratiklere yönelik pozitif bir güven algısı geliştirmeyi beraberinde getirmektedir.

Benzer şekilde, kurumsal güven teorileri de soyut sistemlere (bilime, tıbbı, kurumlara) güven duyma eğilimi yüksek olan bireylerin, bu sistemlerin onayladığı veya entegre ettiği diğer yan unsurlara da daha kolay güven beslediğini savunmaktadır (Giddens, 1990). Dolayısıyla resmi sağlık sisteminin ana aktörleri olan doktor ve hemşirelere yüksek güven duyan bireyler, devlet koruması ve yasal mevzuatla resmi sisteme dahil edilmiş geleneksel şifacıları kurumsal yapının tehlikeli bir alternatifi olarak görmemekte; aksine genel bir sistemik güvenin parçası olarak bu pratiklere karşı da yüksek düzeyde güven geliştirebilmektedir.

2.4 Literatürde Geleneksel Tıbbı Güven Üzerine Yapılan Çalışmalar

Dünyada ve Türkiye’de geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerine yönelik toplumsal güveni, bilgi düzeylerini ve yönelimleri inceleyen ampirik çalışmalar, son yıllarda belirgin bir artış göstermiştir. Uluslararası literatür incelendiğinde, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) küresel sağlık stratejisi raporlarında, üye ülkelerin büyük bir kısmında halkın resmi sağlık hizmetlerinin yanı sıra geleneksel şifacılık pratiklerini de entegre bir biçimde kullandığı vurgulanmaktadır (World Health Organization [WHO], 2013). Gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda da alternatif tıbbı yönelimlerin, kurumsal tıbbın mutlak bir reddinden ziyade, bireysel refahı artırmaya yönelik bir tüketim tercihi olduğu ve sosyo-ekonomik statüyle yakından ilişkili olduğu saptanmıştır (Cockerham, 2016).

Türkiye’deki ampirik literatür incelendiğinde; toplumun farklı kesimlerinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamalarına yönelik tutumlarının çoğunlukla sosyo-demografik faktörler, algılanan gelir düzeyi ve kurumsal güven ekseninde şekillendiği görülmektedir. Nitekim 18 yaş üstü yetişkin bireylerle yapılan kesitsel araştırmalarda, katılımcıların GETAT yöntemleri hakkında yüksek oranda bilgi sahibi oldukları ve bu yöntemleri çoğunlukla modern tıbbi tedavilere destekleyici/tamamlayıcı bir unsur olarak gördükleri saptanmıştır (Hacılar vd., 2024). Benzer şekilde, birinci basamak sağlık hizmetlerine (Aile Sağlığı Merkezlerine) başvuran hastalar üzerinde yürütülen çalışmalarda da bireylerin geleneksel/alternatif tıp yöntemlerini kullanma ve bu yöntemlere güven duyma eğilimlerinin, kronik hastalık yükü ve genel sağlık algısıyla doğrudan ilişkili olduğu; geleneksel yöntemlerin resmi sağlık sistemine bir alternatiften ziyade bütünleşik bir tüketim tercihi olarak hayat dahil edildiği belirlenmiştir (Oral vd., 2016).

Öte yandan, sistemik ve kurumsal güvenin ölçülmesi açısından literatürde sadece hastaların değil, sağlık sisteminin ana taşıyıcısı olan personelin ve hekimlerin tutumları da incelenmiştir. Araştırma görevlisi hekimler ve sağlık müdürlüğü personeliyle yapılan güncel çalışmalar; sağlık profesyonellerinin GETAT uygulamalarının yasal bir zemine oturtulmasını desteklediklerini, hastaların bu yöntemlere yönelik ilgisinin farkında olduklarını ve resmi tıp otoriteleri tarafından denetlenen kurumsal GETAT merkezlerine karşı pozitif bir güven algısına sahip olduklarını ortaya koymaktadır (Akşahin Doğan vd., 2024; İkışık vd., 2021). Tüm bu

ampirik bulgular, Türkiye'de şifacılar ve geleneksel yöntemlere duyulan güvenin; bireysel gelir, eğitim, kronik rahatsızlıklar ve kurumsal tıp aktörlerine olan genel bakış açısı gibi çok değişkenli toplumsal dinamiklerle sıkı sıkıya bağlı olduğunu açıkça göstermektedir.

3. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu bölümde; araştırmanın veri kaynağı, örneklem yapısı, analiz edilecek değişkenlerin nasıl tanımlandığı ve kodlandığı ile tez kapsamında uygulanan istatistiksel yöntemlerin teorik altyapısı açıklanmıştır.

3.1 Veri Seti ve Örneklem Yapısı

Araştırmada veri materyali olarak, Wellcome Trust tarafından dünya genelinde sağlık ve bilim algısını ölçmek amacıyla yürütülen küresel bir araştırma olan Wellcome Global Monitor (WGM) 2018 veri seti kullanılmıştır (Wellcome Trust, 2019).

Veri setinin Türkiye kısmı, ülke genelini temsil edecek şekilde kurgulanmış bir örneklem havuzuna sahiptir. Bu tez çalışması kapsamında, Türkiye örnekleminde yer alan ve araştırmanın bağımlı ile bağımsız değişkenlerine eksiksiz yanıt veren 790 katılımcı analize dahil edilmiştir. Analiz yapılmadan önce veri seti taranmış; eksik veriler (missing values) ve "fikrim yok/yanıt yok" gibi seçenekler temizlenerek nihai örneklem sayısı $N = 790$ olarak belirlenmiştir.

3.2 Değişkenler ve Değişkenlerin Tanımlanması/Kodlanması

Araştırma kapsamında ele alınan kategorik değişkenler, istatistiksel modellemelerin (MCA ve Lojistik Regresyon) doğasına ve literatürdeki teorik çerçeveye uygun olarak yeniden kodlanmış ve gruplandırılmıştır. Bu doğrultuda; orijinal veri setinde "fikrim yok/yanıt yok" seçenekleri hariç tutulduğunda 4'lü Likert yapısına sahip olan "Şifacılar Güven", "Doktor ve Hemşirelere Güven" ve "Aşılar Yönelik Tutum" değişkenleri; analizlerin yorumlanabilirliğini artırmak, hücre frekanslarındaki aşırı dağılmayı ve boş hücre sorununu önlemek amacıyla, ortadaki iki ara kategorinin birleştirilmesi vasıtasıyla 3 kategorili (Düşük, Sınırlı, Yüksek) sıralı bir yapıya indirgenmiştir. Bu sayede hem çok boyutlu uyum analizinde (MCA) hem de Lojistik Regresyon modelinde daha dengeli ve istatistiksel olarak güvenilir sonuçlar elde edilmiştir.

Wellcome Global Monitor (WGM) 2018 veri setinde yer alan "traditional healer" değişkeni de ülkemizdeki literatür ve yasal mevzuat (GETAT yönetmeliği)

dikkate alınarak tez kapsamında “geleneksel ve tamamlayıcı tıp şifacıları/uygulayıcıları” olarak tanımlanmış ve analiz için kodlanmıştır.

- **Bağımlı Değişken:** Araştırmanın ana odak noktası olan, yukarıda belirtildiği gibi 3 kategoriye indirgenmiş şifacılar güven algısıdır (Düşük, Sınırlı, Yüksek).
- **Bağımsız Değişkenler (Sosyo-Demografik):** Katılımcıların Cinsiyet (Erkek, Kadın), Yaş Grupları (15-29, 30-49, 50+), Eğitim Seviyesi (İlköğretim, Ortaöğretim, Yükseköğretim), Algılanan Gelir Düzeyi (Düşük, Yeterli, Yüksek) ve Yerleşim Yeri (Kırsal, Kentsel) değişkenleridir.
- **Bağımsız Değişkenler (Sağlık Tutumları):** Resmi sağlık sistemine güveni temsil eden Doktor ve Hemşirelere Güven (Düşük, Sınırlı, Yüksek) değişkeni ile koruyucu sağlık hizmetlerine yaklaşımı gösteren Aşılar Yönelik Tutum (Olumsuz, Nötr, Olumlu) değişkenleridir. Çok Terimli Lojistik Regresyon analizi aşamasında, frekans yetersizliğinden kaynaklanan matematiksel sınırlılıkları aşmak adına Doktor ve Hemşirelere Güven değişkeninin "Düşük" ve "Sınırlı" kategorileri birleştirilerek referans grubu oluşturulmuştur.

3.3 İstatistiksel Yöntemler ve Analiz Süreci

Verilerin analizi ve hipotezlerin test edilmesi süreci, betimsel istatistiklerden başlayarak çok değişkenli ileri modellemelere uzanan dört aşamalı bir sıra takip edilerek yürütülmüştür.

3.3.1 Betimsel İstatistikler

Araştırma kapsamına dahil edilen katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini, sağlık tutumlarını ve güven algılarını genel olarak özetlemek amacıyla betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda, ele alınan tüm kategorik değişkenlerin örneklem içindeki dağılımlarını ve genel profilini ortaya koymak amacıyla frekans (n) ve yüzde (%) çizelgeleri oluşturulmuştur.

3.3.2 Ki-Kare (χ^2) Bağımsızlık Testi

Değişkenlerin ikerli düzeydeki ilişkilerini ve gruplar arasındaki farkları görmek amacıyla Ki-Kare bağımsızlık testi uygulanmıştır (Agresti, 2013). Analizlerde anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak kabul edilmiştir.

3.3.3 Düzeltilmiş Burt Matrisi Çoklu Uyum Analizi (MCA)

Kategorik değişkenlerin kendi aralarındaki çok boyutlu ilişki örüntülerini ve grafik üzerindeki yakınlıklarını aynı anda görebilmek amacıyla Çoklu Uyum Analizi (MCA) yöntemi tercih edilmiştir. Standart MCA yaklaşımlarında (Gösterge matrisi veya klasik Burt matrisi) ortaya çıkan ve toplam varyansı (ataleti) yapay olarak şişirerek boyutların açıklama oranlarını düşük gösteren matematiksel sınırlılığı gidermek amacıyla analiz öncesinde bir model seçimi süreci yürütülmüştür (Greenacre, 2007).

Söz konusu model seçimi aşamasında; Gösterge Matrisi, Klasik Burt Matrisi, Düzeltilmiş (Adjusted) Burt Matrisi ve Ortak Uyum Analizi (JCA - Joint Correspondence Analysis) yöntemlerinin tamamı veri setine uygulanarak ilk iki boyutta açıkladıkları toplam varyans (atalet) oranları kıyaslanmıştır. Yapılan bu karşılaştırma sonucunda, boyutların açıklama oranını maksimize eden ve veriyi en doğru şekilde haritalandıran Düzeltilmiş Burt Matrisi yönteminin kullanılmasına karar verilmiştir (Greenacre, 2007). Analiz sürecinde ideal boyut sayısının belirlenmesi, kategorilerin boyutlara olan katkılarının incelenmesi ve uzamsal haritalandırma aşamalarında yöntemle ait grafiksel ve istatistiksel çıktılarından yararlanılmıştır.

3.3.4 Çok Terimli Lojistik Regresyon Analizi

Tekli analizlerde görülen ilişkileri, diğer tüm bağımsız değişkenleri kontrol altında tutarak bütüncül bir olasılık modelinde test etmek amacıyla Çok Terimli Lojistik Regresyon Analizi (Multinomial Logistic Regression) uygulanmıştır. Bağımlı değişkenin 3 kategorili yapısı gereği "Düşük Güven" kategorisi referans grup olarak belirlenmiş; "Sınırlı Güven" ve "Yüksek Güven" düzeyleri bu gruba kıyasla modellenmiştir. Modelin veriye genel uyumu ve anlamlılığı; Model Uygunluk testi, Pearson ve Deviance uyum iyiliği istatistikleri, Nagelkerke R-Kare değeri ve

Sınıflandırma Tablosu başarı oranları ile değerlendirilmiştir. Değişkenlerin model genelindeki ve alt kategoriler bazındaki etkileri ise Olabilirlik Oranı ve Wald testleri ile incelenmiş; anlamlı etkenlerin yönü ve olasılık değerleri Lojistik Regresyon katsayıları (B) ve Odds Oranları ($\text{Exp}(B)$) üzerinden %95 güven aralığında yorumlanmıştır (Hosmer ve Lemeshow, 2013).

3.3.5 Veri Analizinde Kullanılan Paket Programlar

Araştırma kapsamında elde edilen verilerin düzenlenmesi, yeniden kodlanması ve tüm istatistiksel modellemelerin yürütülmesi aşamalarında IBM SPSS Statistics ve RStudio paket programlarından yararlanılmıştır. Katılımcıların genel profiline ait frekans/yüzde dağılımları, Ki-Kare bağımsızlık testleri ve Çok Terimli Lojistik Regresyon analizi aşamaları SPSS programında; Çoklu Uyum Analizi (MCA) modellemesi ve bu modele ait ileri düzey grafiksel çıktılar (scree plot, boyut katkıları, biplot ve %95 güven elipsleri) ise RStudio yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

4. BULGULAR

Bu bölümde, Türkiye’de geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) şifacılarına yönelik güven düzeyini ve bu güven algısını şekillendiren unsurları belirlemek amacıyla WGM 2018 veri setinden elde edilen 790 katılımcıya ait veriler analiz edilmiştir. Analiz sürecinde ilk aşamada; örnekleme oluşturan bireylerin cinsiyet, yaş grupları, eğitim seviyesi, algılanan gelir düzeyi ve yerleşim yeri gibi sosyo-demografik özellikleri ile doktor ve hemşirelere güven, aşılarla yönelik tutum ve şifacılara güven düzeylerine ilişkin betimsel dağılımlar incelenmiştir. İkinci aşamada, şifacılara duyulan güvenin sosyo-demografik ve sağlık tutum değişkenlerine göre değişimini test etmek amacıyla iki değişkenli çapraz tablolama yöntemiyle Ki-Kare (X^2) bağımsızlık testleri uygulanmıştır. Üçüncü aşamada, kategorik değişkenlerin kendi aralarındaki çok boyutlu ilişki örüntülerini ve çekim alanlarını görselleştirmek amacıyla, standart matrislerin yapay atalet (inertia) yükseltme yanılığını düzelterek ilk iki boyutta %88,0 gibi yüksek bir açıklama oranına ulaşan Düzeltilmiş Burt Matrisi Çoklu Uyum Analizi (MCA) yöntemi tercih edilmiştir. Bulguların son bölümünde ise, tekli analizlerde gözlenen ilişkileri kontrol değişkenleriyle birlikte bütüncül bir modelde değerlendirmek, risk ve olasılık oranlarını saptamak amacıyla Çok Terimli Lojistik Regresyon Analizi yapılarak tahmin modelleri oluşturulmuştur.

4.1 Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılım

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ait frekans (n) ve yüzde (%) dağılımları Çizelge 4.1'de sunulmuştur.

Çizelge 4.1 Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılım ($N=790$)

Değişken ve Kategoriler	n	%
Cinsiyet		
Erkek	409	51,8
Kadın	381	48,2
Yaş Grupları		
15-29	314	39,7
30-49	333	42,2
50+	143	18,1
Eğitim Seviyesi		
İlköğretim	145	18,4
Ortaöğretim	395	50,0
Yükseköğretim	250	31,6
Algılanan Gelir Düzeyi		
Düşük	286	36,2
Yeterli	380	48,1
Yüksek	124	15,7
Yerleşim Yeri		
Kırsal	153	19,4
Kentsel	637	80,6

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin Çizelge 4.1'de yer alan dağılım sonuçları incelendiğinde; %51,8'inin ($n = 409$) "erkek", %48,2'sinin ($n = 381$) ise "kadın" bireylerden oluştuğu görülmektedir. Yaş grupları dikkate alındığında; katılımcıların %39,7'sinin ($n = 314$) "15-29" yaş, %42,2'sinin ($n = 333$) "30-49" yaş ve %18,1'inin ($n = 143$) "50 ve üzeri" yaş grubunda yer aldığı tespit edilmiştir. Eğitim seviyelerine göre dağılım incelendiğinde; %18,4 ile "ilköğretim" ($n = 145$), %50,0 ile "ortaöğretim" ($n = 395$) ve %31,6 ile "yükseköğretim" ($n = 250$) mezunlarının sıralandığı belirlenmiştir. Algılanan gelir düzeyleri ele alındığında; %36,2'lik ($n = 286$) kesim gelir durumunu "düşük", %48,1'lik ($n = 380$) kesim "yeterli" ve %15,7'lik ($n = 124$) kesim "yüksek" olarak tanımlamıştır. Son olarak yerleşim yeri değişkenine göre; katılımcıların %19,4'ünün ($n = 153$) "kırsal" bölgelerde, %80,6'sının ($n = 637$) ise "kentsel" alanlarda ikamet ettiği saptanmıştır.

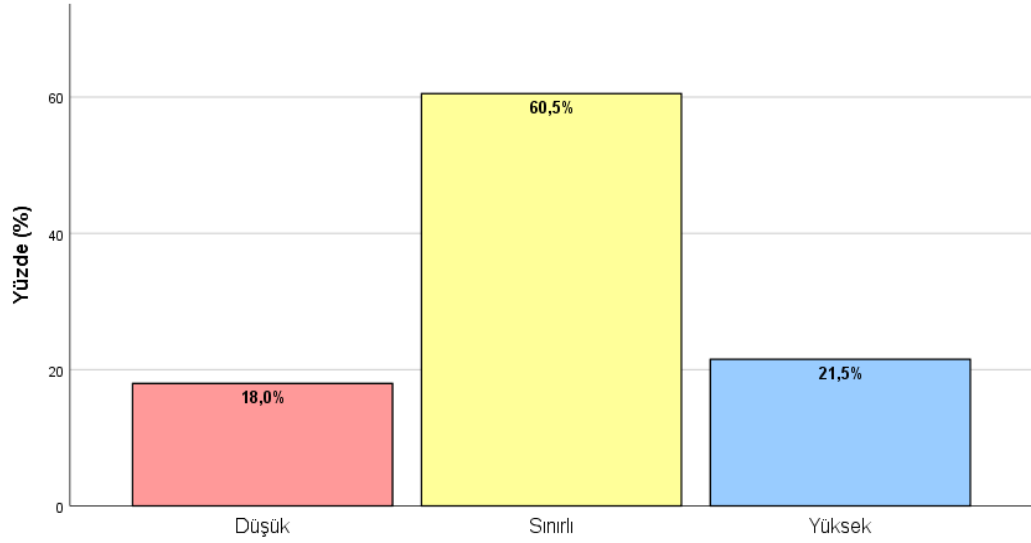
4.2 Katılımcıların Sağlık Tutum ve Güven Algılarına İlişkin Dağılım

Katılımcıların ilgili sağlık tutum ve güven algılarına ait frekans (*n*) ve yüzde (%) dağılımları Çizelge 4.2'de sunulmuştur.

Çizelge 4.2 Katılımcıların Sağlık Tutum ve Güven Algılarına İlişkin Dağılım
(*N*=790)

Değişken ve Kategoriler	<i>n</i>	%
Doktor ve Hemşirelere Güven		
Düşük	33	4,2
Sınırlı	411	52,0
Yüksek	346	43,8
Aşılarla Yönelik Tutum		
Olumsuz	55	7,0
Nötr	81	10,3
Olumlu	654	82,8
Şifacılara Güven		
Düşük	142	18,0
Sınırlı	478	60,5
Yüksek	170	21,5

Katılımcıların sağlık tutumları ve güven algılarına ilişkin Çizelge 4.2'de yer alan dağılım sonuçları incelendiğinde; resmi sağlık sisteminin temel aktörleri olan doktor ve hemşirelere "yüksek" düzeyde güven duyanların oranı %43,8 (*n* = 346) iken, %52,0'lik (*n* = 411) büyük bir kesimin güven seviyesinin "sınırlı" kaldığı, %4,2'sinin (*n* = 33) ise "düşük" düzeyde güven bildirdiği görülmektedir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli unsurlarından biri olan aşılarla yönelik tutumlar dikkate alındığında; %82,8'lik (*n* = 654) ezici bir çoğunluğun "olumlu" bir yaklaşıma sahip olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın, aşılarla "nötr" yaklaşanların oranı %10,3 (*n* = 81), tamamen "olumsuz" tutum sergileyenlerin oranı ise %7,0 (*n* = 55) olarak saptanmıştır. Son olarak, geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) şifacılarına yönelik güven düzeyleri incelendiğinde (Şekil 4.1); şifacılara "yüksek" düzeyde güven duyanların oranı %21,5 (*n* = 170) seviyesinde kalırken, katılımcıların %60,5'inde (*n* = 478) bu güvenin "sınırlı" düzeyle en yüksek paya sahip genel eğilim olduğu ve %18,0'inin (*n* = 142) ise "düşük" düzeyde güven duyduğu belirlenmiştir.



Şekil 4.1 Katılımcıların Geleneksel ve Tamamlayıcı Şifacılarına Yönelik Güven Düzeyleri

4.3 Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Şifacılara Yönelik Güven Düzeylerinin Karşılaştırılması

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) şifacılarına yönelik güven düzeylerinin karşılaştırılmasına ilişkin Ki-Kare testi sonuçları Çizelge 4.3'te sunulmuştur.

Çizelge 4.3 Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Şifacılara Yönelik Güven Düzeylerinin Karşılaştırılması (N=790)

Değişken ve Kategoriler		Şifacılara Güven						X ²	df	p
		Düşük		Sınırlı		Yüksek				
		n	%	n	%	n	%			
Cinsiyet								1,702	2	0,427
Erkek		79	19,3	248	60,6	82	20,0			
Kadın		63	16,5	230	60,4	88	23,1			
Yaş Grupları								0,918	4	0,922
15-29		57	18,2	192	61,1	65	20,7			
30-49		60	18,0	203	61,0	70	21,0			
50+		25	17,5	83	58,0	35	24,5			
Eğitim Seviyesi								3,025	4	0,554
İlköğretim		25	17,2	84	57,9	36	24,8			
Ortaöğretim		67	17,0	240	60,8	88	22,3			
Yükseköğretim		50	20,0	154	61,6	46	18,4			
Algılanan Gelir Düzeyi								24,656	4	<0,001
Düşük		62	21,7	176	61,5	48	16,8			
Yeterli		62	16,3	242	63,7	76	20,0			
Yüksek		18	14,5	60	48,4	46	37,1			
Yerleşim Yeri								1,886	2	0,389
Kırsal		27	17,6	99	64,7	27	17,6			
Kentsel		115	18,1	379	59,5	143	22,4			

Not: İstatistiksel anlamlılık düzeyi ($p < 0,05$) olarak kabul edilmiştir.

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) şifacılarına yönelik güven düzeylerinin karşılaştırılmasına ilişkin Çizelge 4.3'te yer alan Ki-Kare testi sonuçları incelendiğinde; katılımcıların cinsiyetleri ($X^2 = 1,702$; $df = 2$; $p = 0,427 > 0,05$), yaş grupları ($X^2 = 0,918$; $df = 4$; $p = 0,922 > 0,05$), eğitim seviyeleri ($X^2 = 3,025$; $df = 4$; $p = 0,554 > 0,05$) ve yaşadıkları yerleşim yerleri ($X^2 = 1,886$; $df = 2$; $p = 0,389 > 0,05$) ile şifacılaraya yönelik güven düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki ya da farklılık tespit edilememiştir. Buna karşın, katılımcıların algılanan gelir düzeyleri ile şifacılaraya yönelik güven düzeyleri arasında istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır ($X^2 = 24,656$; $df = 4$; $p < 0,001$). Gelir düzeylerine göre oluşan farkın kaynağı incelendiğinde; "sınırlı" güven kategorisinin tüm gelir gruplarında en yüksek paya sahip genel eğilim olduğu görülmekle birlikte, asıl kırılma noktasının "yüksek" şifacı güveni kategorisinde yaşandığı dikkat çekmektedir. Nitekim gelir durumu "yüksek" olan bireylerin şifacılaraya yönelik "yüksek" güven kategorisindeki oranının (%37,1), "yeterli" (%20,0) ve "düşük" (%16,8) gelirli olanların oranını yaklaşık ikiye katlayarak belirgin bir sıçrama gösterdiği saptanmıştır. Diğer taraftan, gelir düzeyi azaldıkça katılımcıların şifacılaraya yönelik "düşük" güven eğilimlerinin de artış yönünde bir seyir izlediği görülmektedir.

4.4 Katılımcıların Sağlık Tutum ve Güven Algılarına Göre Şifacılaraya Yönelik Güven Düzeylerinin Karşılaştırılması

Katılımcıların sağlık tutumları ve genel güven algılarına göre geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) şifacılarına yönelik güven düzeylerinin karşılaştırılmasına ilişkin Ki-Kare testi sonuçları Çizelge 4.4'te sunulmuştur.

Çizelge 4.4 Katılımcıların Sağlık Tutum ve Güven Algılarına Göre Şifacılaraya Yönelik Güven Düzeylerinin Karşılaştırılması (N=790)

Değişken ve Kategoriler	Şifacılaraya Güven						X ²	df	p
	Düşük		Sınırlı		Yüksek				
	n	%	n	%	n	%			
Doktor ve Hemşirelere Güven							69,566	4	<0,001
Düşük	12	36,4	21	63,6	0	0,0			
Sınırlı	87	21,2	273	66,4	51	12,4			
Yüksek	43	12,4	184	53,2	119	34,4			
Aşılaraya Yönelik Tutum							8,713	4	0,069
Olumsuz	16	29,1	28	50,9	11	20,0			
Nötr	14	17,3	56	69,1	11	13,6			
Olumlu	112	17,1	394	60,2	148	22,6			

Not: İstatistiksel anlamlılık düzeyi ($p < 0,05$) olarak kabul edilmiştir.

Katılımcıların sağlık tutumları ve genel güven algılarına göre geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) şifacılarına yönelik güven düzeylerinin karşılaştırılmasına ilişkin Çizelge 4.4'te yer alan Ki-Kare testi sonuçları incelendiğinde; katılımcıların aşılarla yönelik tutumları ile şifacılarına yönelik güven düzeyleri arasındaki ilişki 0,05 anlamlılık düzeyine yakın bir eğilim göstermekle birlikte, istatistiksel olarak tam anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir ($X^2 = 8,713$; $df = 4$; $p = 0,069 > 0,05$). Buna karşın, katılımcıların doktor ve hemşirelere yönelik güven düzeyleri ile şifacılarına yönelik güven düzeyleri arasında istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır ($X^2 = 69,566$; $df = 4$; $p < 0,001$). Doktor ve hemşirelere yönelik güven durumuna göre oluşan farkın kaynağı incelendiğinde; tüm gruplarda şifacılarına yönelik "sınırlı" güven eğiliminin ağırlıklı yapı olduğu görülmekle birlikte, asıl kırılma noktasının "yüksek" şifacı güveni kategorisinde yaşandığı dikkat çekmektedir. Nitekim doktor ve hemşirelere yönelik güven durumu "yüksek" olan bireylerin şifacılarına yönelik "yüksek" güven kategorisindeki oranının (%34,4), güven düzeyi "sınırlı" (%12,4) ve "düşük" (%0,0) olan bireylerin oranını yaklaşık üç katına çıkararak belirgin bir sıçrama gösterdiği saptanmıştır. Diğer taraftan, doktor ve hemşirelere yönelik güven düzeyi azaldıkça katılımcıların şifacılarına yönelik "düşük" güven eğilimlerinin de artış yönünde bir seyir izlediği görülmektedir.

4.5 Uyum Analizi Yöntemlerine Göre Açıklanan Varyans Oranlarının Karşılaştırılması

Uyum analizi yöntemlerine göre açıklanan varyans oranlarının karşılaştırılmasına ilişkin sonuçlar Çizelge 4.5'te sunulmuştur.

Çizelge 4.5 *Uyum Analizi Yöntemlerine Göre Açıklanan Varyans Oranlarının Karşılaştırılması (N=790)*

Matris/Yöntem	1. Boyut Açıklanan Varyans(%)	2. Boyut Açıklanan Varyans(%)	İlk İki Boyutta Toplam Açıklanan Varyans(%)
Gösterge Matrisi (Standart MCA)	11,1	10,8	21,9
Burt Matrisi	16,0	15,2	31,2
Düzeltilmiş Burt Matrisi	47,5	40,5	88,0
Ortak Uyum Analizi (JCA)	-	-	79,0

Not: Ortak Uyum Analizinde (JCA), algoritmik olarak boyutlar ardışık (hiyerarşik) olarak değil, belirlenen boyut sayısına göre eş zamanlı optimize edildiğinden; açıklanan varyans oranları tekil eksenler bazında ayrıştırılamamakta ve iki boyutlu çözüm uzayının tamamı için kümülatif olarak sunulmaktadır.

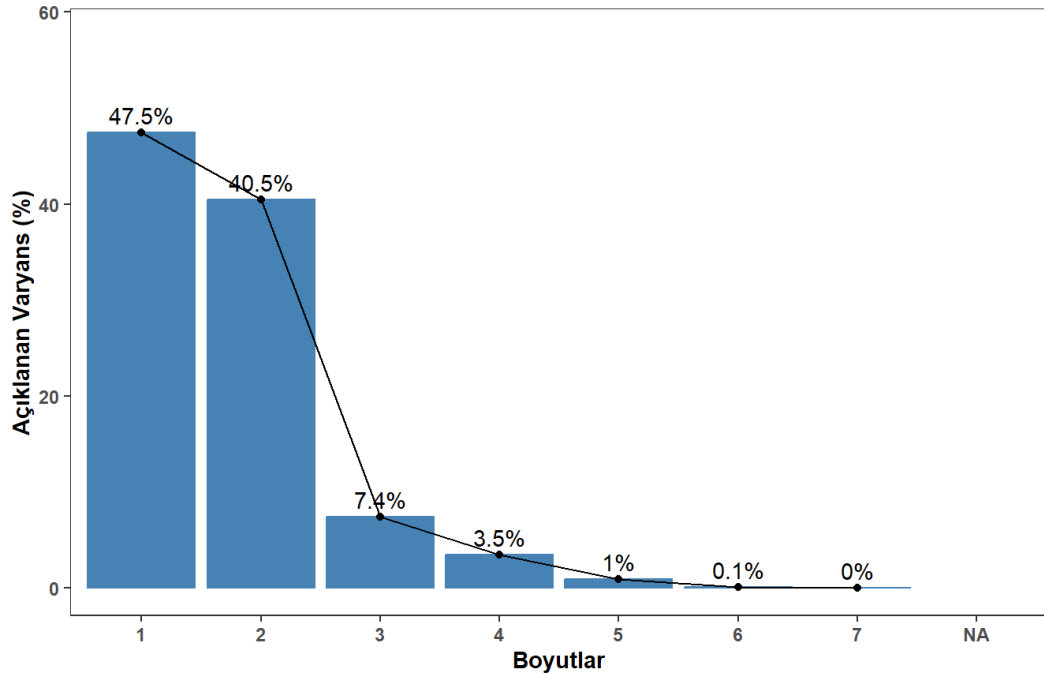
Uyum analizi yöntemlerine göre açıklanan varyans oranlarının karşılaştırılmasına ilişkin Çizelge 4.5'te yer alan bulgular incelendiğinde; Standart MCA (Gösterge Matrisi) ve Burt Matrisi sonuçlarında açıklanan varyans oranlarının oldukça düşük kaldığı görülmektedir. Bu durumun temel nedeni, kategorik verilerde kullanılan standart matrislerin yapısı gereği toplam varyansı (ataleti) suni olarak yüksek hesaplaması ve bu varyans şişmesinin de boyutların açıklama oranlarını aşağı çekmesidir. Çalışmamızda bu matematiksel sınırlılığı gidermek amacıyla Düzeltilmiş (Adjusted) Burt Matrisi kullanılmıştır. Çizelgede görüldüğü üzere Düzeltilmiş Burt Matrisi, ilk iki boyutta %88,0 gibi yüksek bir kümülatif açıklanan varyans oranı sunmuştur. Ortak Uyum Analizi (JCA) de %79,0 ile güçlü bir açıklayıcılık oranı ortaya koymakla birlikte; hem açıklanan varyansı daha da maksimize etmesi hem de kategorilerin iki boyutlu haritalandırmasında daha net yorum imkanı sağlaması nedeniyle analizler Düzeltilmiş Burt Matrisi üzerinden ilerletilmiştir.

4.6 Düzeltilmiş Burt Matrisi Çoklu Uyum Analizi Sonuçları

Çalışmanın önceki bölümlerinde tekil dağılımları betimlenen ve ikiyeşerli ilişkileri Ki-Kare bağımsızlık testi ile analiz edilen sosyo-demografik özellikler (cinsiyet, yaş grupları, eğitim seviyeleri, algılanan gelir düzeyleri, yerleşim yerleri) ile sağlık tutum ve güven algısı değişkenlerinin (doktor ve hemşirelere yönelik güven, aşılarla yönelik tutum, şifacılara yönelik güven) kategorileri arasındaki çok boyutlu ilişki ağını ve olası kümelenme eğilimlerini eş zamanlı olarak değerlendirmek amacıyla Çoklu Uyum Analizi (MCA) uygulanmıştır. Bölüm 4.5'te gerekçelendirildiği üzere, analizler Standart MCA yönteminin toplam atalet değerini yapay olarak şişirme sınırlılığını ortadan kaldıran Düzeltilmiş Burt Matrisi üzerinden yürütülmüştür.

Uygulanan analiz neticesinde elde edilen bulgular, metodolojik bir silsile takip edilerek sırasıyla sunulmuştur. Bu doğrultuda; öncelikle analizin boyut seçimi ve açıklayıcılık düzeyleri değerlendirilmiş, ardından iki boyutlu uzayı inşa eden kategorilerin eksenlere olan katkı payları detaylandırılmıştır. Son aşamada ise, değişken kategorileri arasındaki çok boyutlu ilişki örüntüleri faktöriyel dağılım haritası (biplot) ve katılımcıların şifacılara güven algılarına göre şekillenen bireysel kümelenme eğilimleri güven elipsleri aracılığıyla görselleştirilerek yorumlanmıştır.

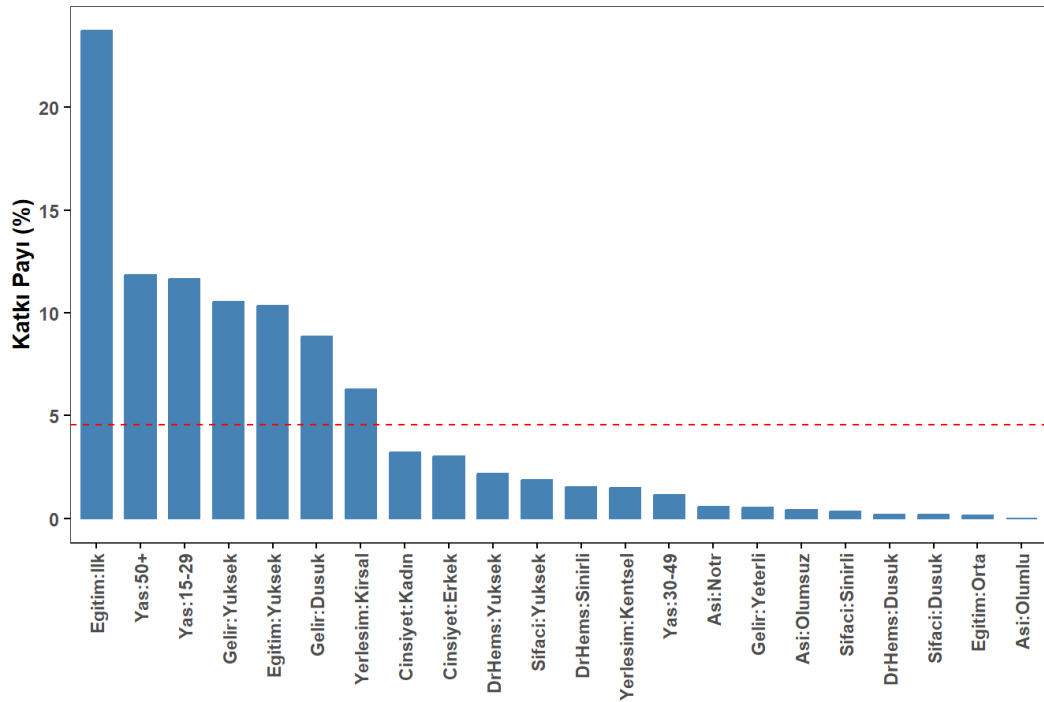
Uygulanan Çoklu Uyum Analizi neticesinde elde edilen boyutların özdeğerleri (atalet değerleri) ve bu boyutların toplam varyansı açıklama oranları Şekil 4.2’de sunulmuştur.



Şekil 4.2 Düzeltilmiş Burt Matrisine Ait Yamaç (Scree) Grafiği

Düzeltilmiş Burt Matrisi üzerinden elde edilen yamaç (scree) grafiği incelendiğinde, veri setindeki toplam değişkenliği (ataleti) açıklamak adına ilk iki boyutun fazlasıyla yeterli ve güçlü bir açıklama kapasitesine sahip olduğu görülmektedir. Grafik verilerine göre, 1. Boyut tek başına toplam düzeltilmiş ataletin %47,5’ini açıklarken; 2. Boyut toplam ataletin %40,5’ini açıklamaktadır. Analize dahil edilen ilk iki boyutun kümülatif (toplam) açıklayıcılık oranı %88,0 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmaktadır. Üçüncü boyuttan itibaren açıklanan varyans oranının keskin bir düşüşle %7,4 seviyesine gerilemesi ve grafikte belirgin bir kırılma (dirsek) noktası oluşturması, analizin iki boyutlu uzayda yürütülmesinin istatistiksel açıdan doğruluğunu ve optimalliğini kanıtlamaktadır. Bu doğrultuda, değişken kategorileri arasındaki ilişkiler ağı ve kümelenme eğilimleri bu ilk iki ana eksen temelinde yorumlanmıştır.

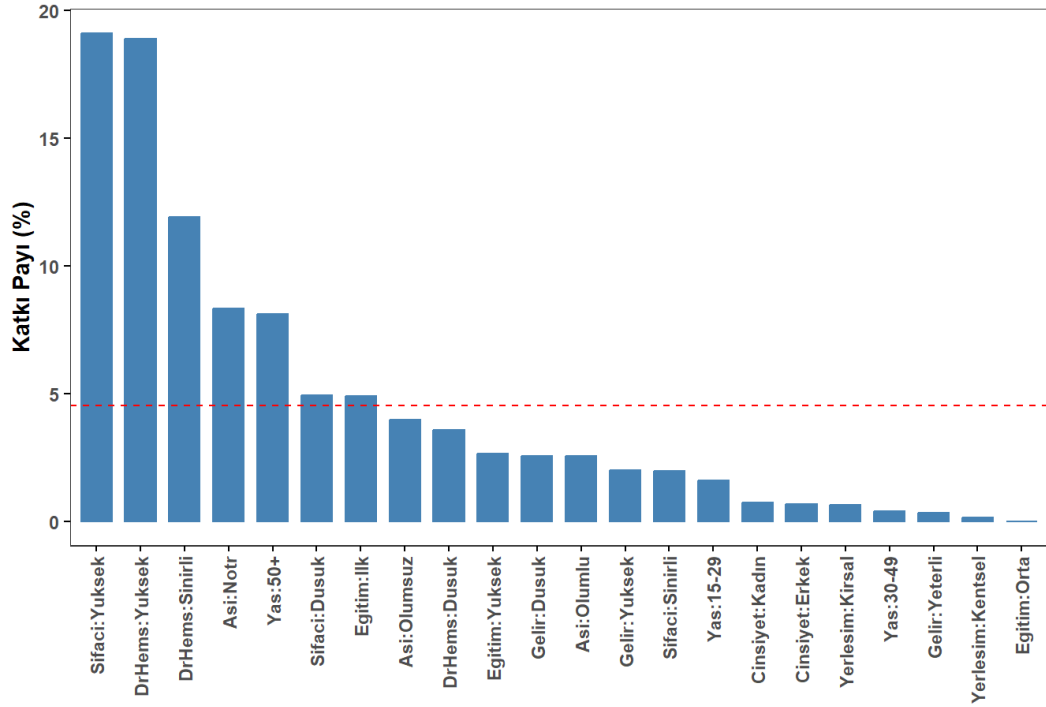
Uygulanan Çoklu Uyum Analizi sonucunda belirlenen 1. Boyuta ait değişken kategorilerinin katkı payları (%) ve bu katkıların anlamlılık eşik değerleri Şekil 4.3’te sunulmuştur.



Şekil 4.3 Değişken Kategorilerinin 1. Boyuta Katkı Payları (%)

Birinci eksenin varyans açıklama kapasitesini şekillendiren temel kategoriler incelendiğinde; kırmızı kesikli çizgi ile sembolize edilen teorik eşik değerinin üzerinde kalan yedi farklı sosyo-demografik unsur göze çarpmaktadır. 1. Boyuta en yüksek katkıyı "Eğitim: İlk" kategorisi sağlarken; bu kategoriye sırasıyla "Yaş: 50+", "Yaş: 15-29", "Gelir: Yüksek", "Eğitim: Yüksek", "Gelir: Düşük" ve "Yerleşim: Kırsal" kategorileri takip etmektedir. Grafik çıktısı genel olarak değerlendirildiğinde, 1. Boyutun Türkiye'deki demografik ve sosyoekonomik yapının temel kutuplarını (eğitim düzeyi, yaş grupları, gelir durumu ve kır-kent ayrımı) kendi üzerinde topladığı görülmektedir. Bu eksen üzerinde geleneksel ve tamamlayıcı tıba (GETAT) duyulan güven algısını şekillendiren asıl sosyo-demografik kırılımlar kodlanmıştır. Eşik değerin altında kalan cinsiyet, aşı tutumları ve şifacı/doktor/hemşire değişkenlerine ait kategorilerin ise 1. Boyutun açıklayıcılığı üzerinde istatistiksel olarak belirleyici bir rol oynamadığı anlaşılmaktadır.

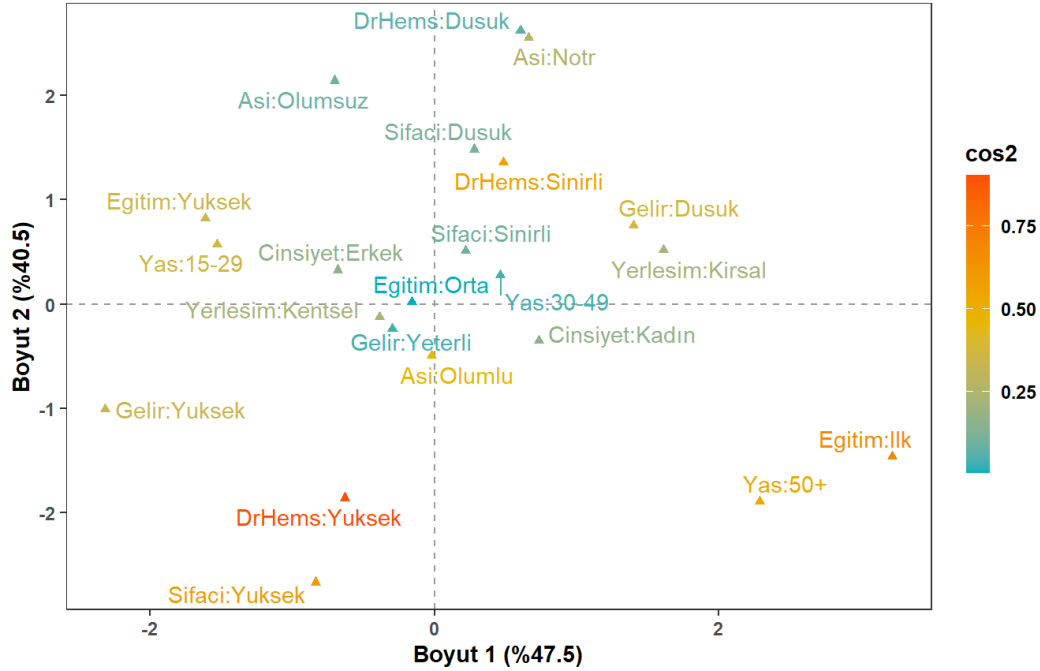
Uygulanan Çoklu Uyum Analizi sonucunda belirlenen 2. Boyuta ait değişken kategorilerinin katkı payları (%) ve bu katkıların anlamlılık eşik değerleri Şekil 4.4'te sunulmuştur.



Şekil 4.4 Değişken Kategorilerinin 2. Boyuta Katkı Payları (%)

Grafikte yer alan katkı payı dağılımları yakından incelendiğinde; kırmızı kesikli çizgi ile gösterilen teorik eşik değerini aşarak bu eksenin toplam ataletine (açıklayıcılığına) anlamlı katkı sağlayan yedi kritik kategori tespit edilmiştir. 1. Boyutun aksine, 2. Boyutun yapısını şekillendiren asıl önemli unsurların; araştırmanın temel odak noktası olan "şifacılar" ile bu odakla ilişkili olarak ele alınan "doktor/hemşire" güveni ve "aşı tutumu" değişkenleri olduğu görülmektedir. Eksenin oluşumuna en yüksek katkıyı sırasıyla "Şifacı: Yüksek" ve "DrHems: Yüksek" kategorileri sağlarken; bu iki güçlü aktörü sırasıyla "DrHems: Sınırlı", "Aşı: Nötr", "Yaş: 50+", "Şifacı: Düşük" ve "Eğitim: İlk" kategorileri takip etmektedir. Grafik çıktısı genel olarak değerlendirildiğinde, 2. Boyutun Türkiye'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamalarına bakış açısını belirleyen "doktor ve hemşirelere duyulan güven", "aşılaraya yönelik tutum" ve "şifacılara güven" arasındaki sınırları ve ilişkileri çizdiği anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, araştırmanın merkezindeki şifacı algısının, bireylerin doktor ve hemşirelere duydukları güven ve aşılaraya karşı yaklaşımlarıyla bu boyutta nasıl güçlü bir kırılma yarattığı net bir şekilde görülmektedir. Eşik değerinin altında kalan cinsiyet, yerleşim yeri ve gelir durumu gibi kategorilerin ise 2. Boyutun ataleti üzerinde belirleyici bir rol oynamadığı tespit edilmiştir.

Uygulanan Çoklu Uyum Analizi sonucunda belirlenen ilk iki boyut temelinde, analize dahil edilen tüm değişken kategorilerinin renk kodlarıyla ayrıştırılarak iki boyutlu uzaydaki geometrik konumlarını, birbirlerine olan yakınlıklarını ve algısal ilişkilerini gösteren faktöriyel dağılım haritası (biplot) Şekil 4.5'te sunulmuştur.



Şekil 4.5 Düzeltilmiş Burt Matrisi Değişken Kategorileri Faktöriyel Dağılım Haritası (Biplot)

Grafikteki iki boyutlu düzlem incelendiğinde; söz konusu kategorilerin mekansal dağılımları, birbirlerine olan mesafeleri ve temsil kalitelerini gösteren cos2 değerleri arasındaki ilişkiler net bir şekilde görülmektedir. Haritada yatay eksen (1. Boyut) sosyo-demografik ayrışmayı temsil ederken, dikey eksen (2. Boyut) sağlık aktörlerine güven ve aşı tutumunu yansıtmaktadır. Haritadaki renk skalası; mavi ve yeşil tonlardan kırmızı ve turuncu tonlara doğru artan cos2 değerlerini, dolayısıyla kategorilerin bu uzaydaki temsil kalitesinin ve yapılacak yorumların istatistiksel güvenilirliğinin yüksekliğini göstermektedir.

Haritanın sol alt kadranında, tezin ana odak noktası olan şifacılara yüksek düzeyde güven duyanlar ile temsil kalitesi oldukça yüksek olan doktor ve hemşirelere yönelik güveni yüksek olanların birbirine oldukça yakın konumlandığı görülmektedir. Dikey eksenin alt (negatif) kutbunda şekillenen bu yüksek güven odaklarına; Boyut 2 (sağlık tutum ve güven algısı) ekseninde paralel bir hizalanma sergileyen, haritanın sağ alt kadranındaki 50 yaş ve üzeri ileri yaş grubu ile ilk eğitim seviyesindeki bireyler ve sol kadran sınırındaki yüksek gelir grubundakiler konumsal olarak eşlik etmektedir.

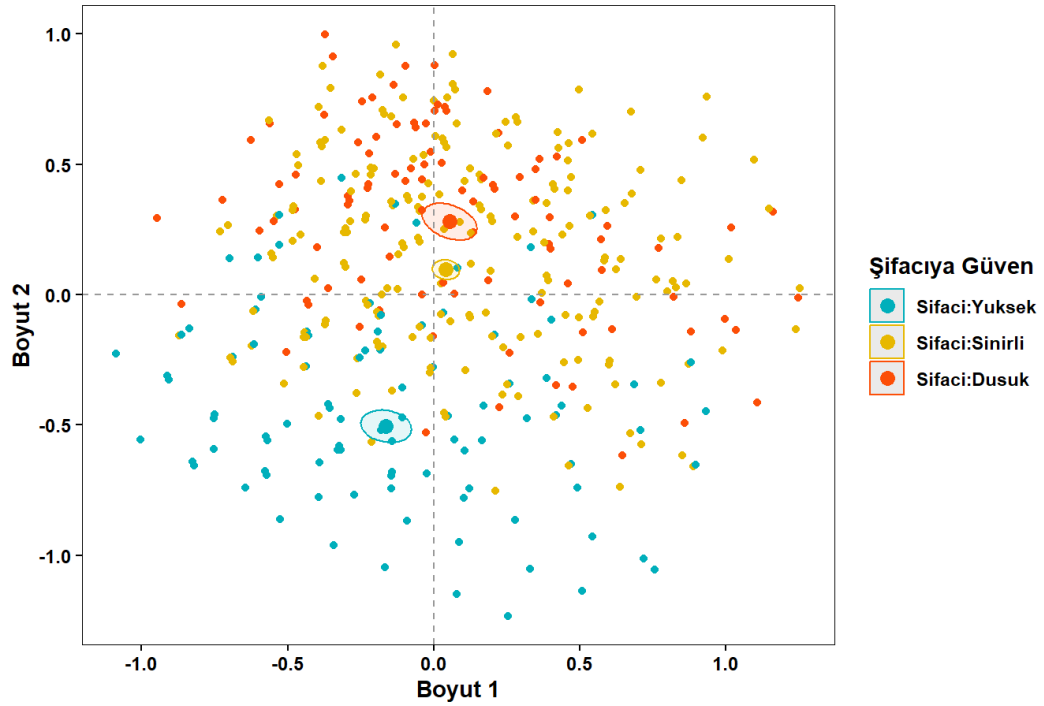
Bu yerleşim, şifacılar ve doktor/hemşirelere yönelik yüksek güven eğiliminin belirgin bir sosyo-demografik tabanla ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu geniş kümenin dikey eksene yakın bölgedeki aşılara karşı olumlu tutum sergileyenlerle olan mesafesi, hem şifacıya hem de doktor ve hemşirelere yüksek güven besleyen bu profilin aşılara karşı da olumlu bir yaklaşıma sahip olduğunu doğrulamaktadır.

Haritanın üst kısmında ise şifacılar güveni düşük olanlar; doktor ve hemşirelere güveni düşük olanlar, aşı karşıtı tutuma sahip olanlar ve aşılara karşı nötr tutuma sahip gruplarla bir arada kümelenmiştir. Bu geometrik yerleşim, şifacılar güvenmeyen bireylerin bu tutumunun doktor ve hemşire güvensizliği ile aşı karşıtlığı/kararsızlığı ile dikey eksen boyunca bir arada hareket ettiğini göstermektedir. Ancak bu üst bölgedeki kategorilerin genel olarak düşük $\cos^2$ değerlerine (soğuk tonlara) sahip olması, söz konusu şüpheci profilin haritadaki temsil kalitesinin sol alt kadrandaki yüksek güven odaklarına kıyasla matematiksel olarak daha zayıf olduğunu ortaya koymaktadır.

Haritanın sol üst kadranda yüksek eğitimli bireyler ve 15-29 yaş arası genç nüfus birbirine yakın kümelenerek genç ve yüksek eğitimli profilin şifacılar yüksek güven duyan odak noktasından uzaklaştığını göstermektedir. Sağ üst kadranda ise düşük gelir grubu ile kırsal alanda yaşayanlar mekansal bir yakınlık sergilemektedir. Son olarak, düşük $\cos^2$ değerlerine sahip olan şifacılar sınırlı düzeyde güvenenler, orta eğitim seviyesindekiler, 30-49 yaş grubu ve geliri yeterli olanlar ile teorik eşik değerin altında kalan kadın, erkek ve kentsel yerleşim grupları orijin (0,0 merkez noktası) etrafında toplanarak genel ortalamayı yansıtmaktadır. Bu geometrik yığılma, söz konusu grupların boyutlar üzerinde keskin bir kutuplaşma yaratmadığını ve örneklem genel ortalamasına yakın bir eğilim sergilediğini doğrulamaktadır. Buna karşılık, doktor ve hemşirelere yönelik sınırlı güven kategorisi, yüksek bir $\cos^2$ temsil gücüyle üst kadrana doğru tırmanarak sistemik şüphecilik alanına doğru güçlü bir eğilim sergilemektedir. Özetle, ortaya çıkan bu iki boyutlu dağılım haritası, şifacılar yönelik güven kategorilerinin doktor ve hemşirelere güven ile aşılara yönelik tutum değişkenleriyle dikey eksen (Boyut 2) boyunca birlikte kutuplaştığını ve bu algısal yapının temel sosyo-demografik kırılımlarla ilişkili olduğunu göstermektedir.

Uygulanan Çoklu Uyum Analizi sonucunda belirlenen ilk iki boyut temelinde, analize dahil edilen katılımcıların şifacılar yönelik güven algılarına göre ayrıştırılarak iki boyutlu uzaydaki bireysel konumlarını, kümelenme yoğunluklarını ve gruplar arası

istatistiksel mesafeleri gösteren dağılım grafiği ve güven elipsleri Şekil 4.6’da sunulmuştur.



Şekil 4.6 Şifacılar Güven Algısına Göre Katılımcı Kümelerinin Dağılımı ve Güven Elipsleri

Elde edilen dağılım haritası ve güven elipsleri detaylı olarak incelendiğinde; örneklemin, şifacılar yönelik üç ana güven kategorisi ekseninde net ve keskin bir ayrışma sergilediği görülmektedir. Grafikte Boyut 1 yatay eksenini, Boyut 2 ise dikey eksenini temsil etmektedir. Her bir güven grubunun merkezini ve yoğunluk bölgesini simgeleyen güven elipslerinin birbiriyle çakışmaması, şifacılar yönelik tutumların Boyut 2 eksenini boyunca istatistiksel olarak anlamlı ve keskin bir farklılaşma yarattığını doğrulamaktadır.

Haritanın alt kısmında (Boyut 2 negatif değerler bölgesinde) mavi renkli noktalarla temsil edilen şifacılar yüksek güven duyan katılımcıların kümelendiği görülmektedir. Bu grubun güven elipsi, dikey eksenin en alt bölgesinde konumlanarak diğer gruplardan tamamen ayrılmaktadır. Bu durum, şifacılar yönelik yüksek güven besleyen bireylerin tutumsal olarak oldukça homojen bir yapı sergilediğini ve haritanın bu bölgesinde karakteristik bir küme oluşturduğunu kanıtlamaktadır.

Buna karşılık, haritanın üst kısmında (Boyut 2 pozitif değerler bölgesinde) kırmızı renkli noktalarla temsil edilen şifacılar güveni düşük olan katılımcı kümesi yer almaktadır. Bu kümenin elipsi, dikey eksenin üst kutbunda konumlanarak yüksek

güven grubuna taban tabana zıt bir yerleşim sergilemektedir. İki grup arasındaki bu dikey mesafe, katılımcıların şifacılara yönelik güven algısının dikey eksen (Boyut 2) boyunca net bir kutuplaşma yaşadığını ve bireylerin şifacılara duydukları güven seviyesine göre harita üzerinde fiziksel olarak farklı uzaylara savrulduğunu göstermektedir.

Haritanın merkezinde ve hafifçe sağ-orta bölgesinde yer alan sarı renkli noktalar ise şifacılara yönelik sınırlı düzeyde güveni olan katılımcıları temsil etmektedir. Bu grubun elipsinin orijin (0,0) noktasına yakınlığı, sınırlı güven algısına sahip bireylerin boyutlar üzerinde radikal bir kutuplaşma yaratmadığını ve örneklem genel ortalamasını temsil eden bir denge noktasında durduklarını doğrulamaktadır. Özetle bu dağılım; katılımcıların şifacılara duydukları güven seviyesinin, Çoklu Uyum Analizi düzleminde bireysel konumları istatistiksel olarak birbirinden tamamen farklı kümeler ve koordinat uzaylarına ayıran temel bir varyans ayrıştırıcısı olduğunu ortaya koymaktadır.

4.7 Katılımcıların Şifacılara Yönelik Güven Düzeylerini Belirleyen Etmenlere İlişkin Lojistik Regresyon Analizi

Katılımcıların geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) şifacılarına yönelik güven düzeylerini şekillendiren sosyo-demografik özellikleri ile sağlık tutum ve güven algılarına ilişkin etmenleri bir arada değerlendirmek amacıyla uygulanan Çok Terimli Lojistik Regresyon analizi sonuçları Çizelge 4.6’da sunulmuştur.

Çizelge 4.6 Katılımcıların Şifacılara Yönelik Güven Düzeylerini Belirleyen Etmenlere İlişkin Lojistik Regresyon Analizi (N=790)

Değişken ve Kategoriler	Şifacılara Güven (Ref:Düşük)									
	Sınırlı Güven					Yüksek Güven				
	B	S.E.	p	Exp(B)	%95 C.I.	B	S.E.	p	Exp(B)	%95 C.I.
Cinsiyet (Ref: Kadın; $X^2 = 1,766$; $p = 0,414$)										
Erkek	-0,121	0,198	0,541	0,886	[0,60 - 1,31]	-0,317	0,244	0,195	0,729	[0,45 - 1,18]
Yaş Grupları (Ref: 50+; $X^2 = 0,154$; $p = 0,997$)										
15-29	0,059	0,303	0,846	1,061	[0,59 - 1,92]	-0,034	0,368	0,927	0,967	[0,47 - 1,99]
30-49	0,074	0,283	0,793	1,077	[0,62 - 1,88]	0,020	0,340	0,953	1,020	[0,52 - 1,99]
Eğitim Seviyesi (Ref: Yüksek; $X^2 = 4,234$; $p = 0,375$)										
İlk	0,128	0,318	0,687	1,137	[0,61 - 2,12]	0,616	0,389	0,114	1,851	[0,86 - 3,97]
Orta	0,169	0,222	0,447	1,184	[0,78 - 1,83]	0,479	0,281	0,089	1,614	[0,93 - 2,80]
Algılanan Gelir Düzeyi (Ref: Düşük; $X^2 = 18,292$; $p = 0,001$)										
Yeterli	0,287	0,211	0,174	1,333	[0,88 - 2,02]	0,279	0,272	0,305	1,322	[0,78 - 2,25]
Yüksek	0,206	0,320	0,520	1,229	[0,66 - 2,30]	1,142	0,367	0,002	3,134	[1,53 - 6,43]
Yerleşim Yeri (Ref: Kentsel; $X^2 = 0,695$; $p = 0,707$)										
Kırsal	0,078	0,249	0,755	1,081	[0,66 - 1,76]	-0,127	0,316	0,688	0,881	[0,47 - 1,64]
Doktor ve Hemşirelere Güven (Ref: Düşük/Sınırlı; $X^2 = 50,166$; $p < 0,001$)										
Yüksek	0,292	0,214	0,171	1,339	[0,88 - 2,04]	1,549	0,259	<0,001	4,707	[2,83 - 7,83]
Aşılara Yönelik Tutum (Ref: Olumsuz; $X^2 = 4,239$; $p = 0,375$)										
Olumlu	0,585	0,339	0,085	1,794	[0,92 - 3,49]	0,185	0,445	0,677	1,204	[0,50 - 2,88]
Nötr	0,775	0,440	0,078	2,171	[0,92 - 5,14]	0,133	0,595	0,824	1,142	[0,36 - 3,67]

Kurulan Çok Terimli Lojistik Regresyon modelinin istatistiksel açıdan bir bütün olarak anlamlılığını ve açıklayıcılığını değerlendirmek amacıyla öncelikle Model Uygunluk Bilgisi (Model Fitting Information) sonuçları incelenmiştir. Sadece sabit terimin yer aldığı model (Intercept Only) ile bağımsız değişkenlerin eklendiği nihai model (Final) arasındaki farkın istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı olduğu saptanmıştır ($X^2 = 91,861$; $df = 22$; $p < 0,001$). Bu durum, modele dahil edilen sosyo-demografik özellikler ile sağlık tutum ve güven algısı değişkenlerinin, katılımcıların şifacılaraya yönelik güven düzeylerini tahmin etmede bir bütün olarak modele anlamlı ve güçlü bir katkı sağladığını doğrulamaktadır.

Modelin veriye genel uyumunu test eden Uyum İyiiliği (Goodness-of-Fit) çizelgesindeki Pearson ($X^2 = 449,403$; $df = 430$; $p = 0,250$) ve Sapma (Deviance) testi sonuçları ($X^2 = 434,477$; $df = 430$; $p = 0,431$) incelendiğinde, elde edilen p değerlerinin 0,05 eşik değerinden büyük çıkması, modelin veriye uyumunun kabul edilebilir düzeyde olduğunu ve model-veri uyumunun sağlandığını göstermektedir. Bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkendeki (şifacılaraya güven) değişimi açıklama oranını ortaya koyan Pseudo R-Square değerleri incelendiğinde; Nagelkerke R-Kare değerinin 0,129 olduğu görülmüştür. Bu değer, doğrusal regresyondaki belirtme katsayısına benzer bir yaklaşımla, modele eklenen sosyo-demografik özellikler ile sağlık tutum ve güven algısı etmenlerinin, katılımcıların şifacılaraya yönelik güven düzeylerini tahmin etmede modelin açıklayıcılık kapasitesinin %12,9 olduğunu ortaya koymaktadır. Modelin doğru tahmin ve ayırt etme gücünü gösteren Sınıflandırma Çizelgesi (Classification Table) sonuçları incelendiğinde; modelin genel doğru sınıflandırma (başarı) oranının %61,6 olduğu tespit edilmiştir. Kategoriler bazında modelin tahmin başarısı incelendiğinde, bağımlı değişkenin çoğunluk grubunu oluşturan Sınırlı Güven kategorisinde %96,0 gibi oldukça yüksek bir doğru sınıflandırma oranı yakalandığı görülmüştür. Buna karşılık, modelin Yüksek Güven kategorisindeki doğru tahmin oranı %16,5'te kalmış, örneklem frekansı görece daha düşük olan Düşük Güven kategorisinde ise doğru sınıflandırma yapılamamıştır (%0,0). Alt kategorilerdeki bu asimetric tahmin performansı veri setindeki grup frekanslarının heterojen dağılımından kaynaklanmakla birlikte, modelin yakaladığı %61,6'lık genel doğru sınıflandırma başarısı, parametre tahminlerinin yorumlanması ve model geçerliliği için istatistiksel açıdan kabul edilebilir düzeydedir.

Çizelge 4.6'da yer alan değişkenlerin modele olan genel etkilerini bütünsel olarak belirlemek amacıyla yürütülen Olabilirlik Oranı Testleri (Likelihood Ratio Tests) sonuçları incelendiğinde; modele dahil edilen etmenler arasında katılımcıların algılanan gelir düzeyi ($X^2 = 18,292$; $df = 4$; $p = 0,001$) ile doktor ve hemşirelere yönelik güven düzeylerinin ($X^2 = 50,166$; $df = 2$; $p < 0,001$) şifacılara duyulan güven üzerinde istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı birer belirleyici olduğu saptanmıştır. Buna karşılık; model genelinde aşılaraya yönelik tutum ($p = 0,375$), cinsiyet ($p = 0,414$), eğitim seviyesi ($p = 0,375$), yerleşim yeri ($p = 0,707$) ve yaş grupları ($p = 0,997$) değişkenlerinin şifacılara yönelik güven algısı üzerinde doğrudan, bağımsız ve çok değişkenli bir ana etkisi tespit edilememiştir.

Çok Terimli Lojistik Regresyon analizinde, bağımlı değişken olan şifacılara güven düzeyinin referans kategorisi "Düşük Güven" olarak belirlenmiş ve diğer güven düzeyleri (Sınırlı ve Yüksek) bu gruba kıyasla modellenmiştir. Parametre Tahminleri (Parameter Estimates) çizelgesi incelendiğinde; ilk olarak "Sınırlı Güven" ile "Düşük Güven" kategorilerinin karşılaştırıldığı ilk lojit modelde, bağımsız değişkenlerin kendi referans kategorilerine kıyasla (Kadın, 50+ Yaş, Yüksek Eğitim, Düşük Gelir, Kentsel Yerleşim, Düşük/Sınırlı Doktor Güveni ve Olumsuz Aşı Tutumu) hiçbir alt kategorinin istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma yaratmadığı görülmektedir ($p > 0,05$). Bir başka ifadeyle, katılımcıların sosyo-demografik özellikleri veya kendi referans gruplarına göre değerlendirilen sağlık tutum ve güven algısı etmenleri, şifacılara yönelik düşük güven ile sınırlı güven arasındaki ayrımında bağımsız birer olasılık (risk) faktörü olarak öne çıkmamaktadır.

Buna karşılık, "Yüksek Güven" ile "Düşük Güven" kategorilerinin karşılaştırıldığı ikinci lojit modelde, istatistiksel olarak son derece çarpıcı ve anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Bu modelde, algılanan gelir düzeyi "yeterli" olan bireyler ile referans grubu (düşük gelir) arasında şifacılara yüksek güven duyma açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmazken ($p = 0,305$); algılanan gelir düzeyi "yüksek" olan bireylerin, gelir düzeyi "düşük" olan referans grubuna kıyasla şifacılara yüksek düzeyde güven duyma olasılığının 3,134 kat daha fazla olduğu saptanmıştır ($B = 1,142$; S.E. = 0,367; $p = 0,002$; $\text{Exp}(B) = 3,134$; %95 C.I. = [1,53 - 6,43]). Bu bulgu, ekonomik refah düzeyindeki artışın şifacılara yönelik tam güven algısını güçlü bir şekilde desteklediğini ortaya koymaktadır.

Modelin ve araştırmanın en güçlü belirleyicisi olarak öne çıkan bulguya göre ise doktor ve hemşirelere yönelik güveni "yüksek" olan katılımcıların, frekans dağılımı doğrultusunda referans grubu olarak belirlenen "düşük/sınırlı" güven grubuna kıyasla, şifacılara yüksek düzeyde güven duyma olasılığının tam 4,707 kat daha yüksek olduğu saptanmıştır ($B = 1,549$; S.E. = 0,259; $p < 0,001$; $\text{Exp}(B) = 4,707$; %95 C.I. = [2,83 – 7,83]). Bu ileri düzeyde anlamlı sonuç, Türkiye'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) şifacılarına duyulan yüksek güvenin, kurumsal tıp aktörlerine yönelik bir reaksiyondan veya sistemik bir güvensizlikten beslenmediğini açıkça göstermektedir. Modeldeki diğer sosyo-demografik (cinsiyet, yaş, eğitim, yerleşim) ve tutumsal (aşı tutumu) değişkenlerin yüksek güven lojiti üzerinde de istatistiksel olarak bağımsız bir anlamlılığı bulunmamaktadır ($p > 0,05$).

5. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Bu bölümde, tezin bulgular kısmında elde edilen istatistiksel sonuçlar sağlık sosyolojisi ve ilgili literatür çerçevesinde tartışılmakta, araştırmanın kuramsal argümanları ile gelecek çalışmalar için öneriler sunulmaktadır.

5.1 Giriş ve Araştırmanın Genel Değerlendirmesi

Bu çalışmada, Wellcome Global Monitor (WGM) 2018 veri seti üzerinden Türkiye’de geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) şifacılarına yönelik güven düzeyleri ve bu güven algısını şekillendiren çok boyutlu örüntüler; betimsel istatistikler, Ki-Kare bağımsızlık testleri, Çoklu Uyum Analizi (MCA) ve Çok Terimli Lojistik Regresyon Analizi yöntemleriyle incelenmiştir.

Örneklem genelinde katılımcıların %60,5’inin şifacılarına yönelik "sınırlı" düzeyde bir güven beyan etmesi, konunun toplum nezdinde radikal bir reddediş veya körü körüne bir kabulden ziyade, temkinli ve gri bir alanda konumlandığını göstermektedir. Bu gri alanın hangi sosyo-demografik ve tutumsal etkenlerle "yüksek" veya "düşük" güven seviyelerine doğru değiştiği, tezin istatistiksel modellemelerinin ana çıkış noktasını oluşturmuştur.

5.2 Şifacılarına Yönelik Güven Algısının Bütünleşik Değerlendirilmesi

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular incelendiğinde, iki değişkenli analizlerden elde edilen sonuçların, Çoklu Uyum Analizi (MCA) gibi geometrik bir görselleştirme yöntemiyle ve Çok Terimli Lojistik Regresyon gibi çok değişkenli bir olasılık modeliyle tam bir uyum içinde birbirini doğruladığı görülmektedir. Modeller arasındaki bu yöntemsel tutarlılık, iki temel anahtar değişken üzerinden net bir şekilde okunabilmektedir.

5.2.1 Algılanan Gelir Düzeyinin Güven Algısı Üzerindeki Etkisi

Ki-Kare bağımsızlık testi sonuçlarında, bireylerin algılanan gelir düzeyi ile şifacılarına yönelik güven seviyeleri arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Bu farkın kaynağı incelendiğinde, gelir durumu "yüksek" olan

katılımcıların şifacılar yüksek düzeyde güven duyma oranının (%37,1), düşük gelirli olanların (%16,8) iki katını aştığı görülmüştür. İki değişkenli düzeyde ortaya çıkan bu fark, Düzeltilmiş Burt Matrisi tabanlı Çoklu Uyum Analizi (MCA) faktöriyel haritasında (Şekil 4.5) "Gelir: Yüksek" ve "Şifacı Güveni: Yüksek" kategorilerinin sol alt kadranda birbirine çok yakın kümelenmesiyle mekansal olarak da doğrulanmıştır. Söz konusu ilişki örüntüsü nihai Çok Terimli Lojistik Regresyon analizi sonuçlarıyla da desteklenmiştir. Modelde tüm sosyo-demografik etmenler kontrol edildiğinde dahi, gelir düzeyi yüksek olan bireylerin, düşük gelirli referans grubuna kıyasla şifacılar yüksek düzeyde güven duyma olasılığının 3,134 kat daha fazla olduğu saptanmıştır.

Tüm bu bulgular bir arada değerlendirildiğinde, Türkiye'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp pratiklerine yönelik yüksek güvenin, literatürdeki yaygın ve yüzeysel ön yargıların aksine, yoksulluktan veya modern sağlık hizmetlerine ekonomik erişimsizlikten kaynaklanan çaresiz bir yönelim olmadığını ortaya koymaktadır. Aksine, ekonomik refah düzeyindeki artış, bu tür alternatif ve tamamlayıcı hizmetleri birer tüketim ve yaşam tarzı tercihi olarak satın alma veya bu pratiklere güven duyma eğilimini arttırmaktadır. Nitekim literatürde hastane örnekleminde yapılan bazı kısıtlı yerel çalışmalar gelir düzeyinin GETAT yöntemlerine yönelik tutumlar üzerinde doğrudan anlamlı bir fark yaratmadığını savunurken (Hacılar vd., 2024); bizim Türkiye genelini temsil eden katmanlı makro modelimiz kurumsal güven ve sosyo-ekonomik faktörler kontrol altına alındığında yüksek gelirin şifacılar tam güven duyma olasılığını güçlü bir şekilde artırdığını ampirik olarak kanıtlamaktadır.

5.2.2 Doktor ve Hemşirelere Güven Düzeyinin Güven Algısı Üzerindeki Etkisi

Araştırmanın literatüre katkı sunacak en özgün ve dikkate değer bulgusu, resmi sağlık sisteminin ana aktörleri olan doktor ve hemşirelere duyulan güven ile şifacılar güven arasındaki pozitif yönlü doğrusal ilişkidir. Ki-Kare analizinde, doktor ve hemşirelere güveni "yüksek" olan bireylerin şifacılar da yüksek düzeyde güvenme oranı %34,4 iken, kurumsal sisteme güveni düşük olanlarda bu oranın %0,0 olması ilişkinin yönünü net bir şekilde çizmiştir. Bu durum MCA haritasında (Şekil 4.5), "Doktor/Hemşire Güveni: Yüksek" ve "Şifacı Güveni: Yüksek" kategorilerinin sol alt kadranda birbirine çok yakın konumlanmasıyla görsel bir kanıt dönüşmüştür. Çok Terimli Lojistik Regresyon modelinde ise bu ilişki modelin en güçlü belirleyicisi

olarak öne çıkmış; doktor ve hemşirelere yönelik güveni yüksek olan katılımcıların, referans grubuna kıyasla şifacılaraya yüksek güven duyma olasılığının tam 4,707 kat daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Elde edilen bu ileri düzeyde anlamlı sonuç, Türkiye'de şifacılaraya yönelimlerin kurumsal tıp kurumlarına yönelik bir reaksiyondan veya modern tıbbaya duyulan bir öfkeden beslenmediğini açıkça kanıtlamaktadır. Bireyler resmi sağlık sistemini dışlamak veya alternatifleriyle yer değiştirmek yerine, geleneksel şifacıları kurumsal yapının birer tamamlayıcısı olarak görmekte ve bütünlük bir sağlık inancı geliştirmektedir. Elde edilen bu bulgu, hem halk nezdinde hem de sağlık personeli ve hekim düzeyinde kurumsal sistemle GETAT pratiklerinin birbirini dışlamayan bütünlük unsurları olarak değerlendirildiğini gösteren yerel çalışmaların sonuçlarını ampirik olarak desteklemektedir (Akşahin Doğan vd., 2024; İkışık vd., 2021; Oral vd., 2016).

5.2.3 Anlamsız Çıkan Faktörlerin Değerlendirilmesi: Demografik Özellikler ve Aşı Tutumu

Tez kapsamında incelenen sosyo-demografik değişkenler (cinsiyet, yaş grupları, eğitim seviyesi ve yerleşim yeri) ile aşılara yönelik tutum değişkeninin, şifacılaraya yönelik güven düzeyi ile olan ilişkisi Ki-Kare bağımsızlık testlerinde ve Çok Terimli Lojistik Regresyon modelinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Literatürde genellikle yaşlı, az eğitilmiş veya kırsal bölgelerde yaşayan bireylerin geleneksel tıbbaya daha eğilimli olduğu yönündeki yaygın sosyolojik kabullerin aksine (Cockerham, 2016; WHO, 2013), bu çalışmada demografik kısıtlımların anlamsız çıkması son derece önemli bir bulgudur. Bu durum, Türkiye’de GETAT şifacılarına yönelik güven algısının belirli bir yaş, cinsiyet, yerleşim yeri veya eğitim seviyesine hapsolmadığını; aksine toplumun genelinde demografik özelliklerden bağımsız olarak homojen bir yapı sergilediğini göstermektedir.

Benzer şekilde, aşılara yönelik tutumun iki değişkenli düzeyde ve Lojistik Regresyon modelinde doğrudan anlamlı bir etki göstermemesi, bu değişkenin şifacılaraya güven üzerinde tek başına doğrusal bir belirleyici olmadığını ortaya koymaktadır. Ancak bu tutumsal değişkenin doğrusal modellerde anlamsız çıkmasına rağmen, Çoklu Uyum Analizi (MCA) gibi çok boyutlu geometrik uzayda (Boyut 2)

doktor güveniyle birlikte dikey ekseninde kutuplaşması yöntemsel açıdan dikkat çekicidir. Bu durum, aşı tutumunun şifacılara güveni doğrudan ve izole bir şekilde etkilemediğini, aksine arka planda şekillenen daha genel bir "sağlık şüpheliği" örüntüsünün dolaylı bir parçası olarak mekansal uzayda yer aldığını göstermektedir. Dolayısıyla güven algısını doğrudan ve doğrusal olarak asıl şekillendiren unsurlar demografik kimlikler veya aşı inancı değil, tamamen ekonomik imkanlar (gelir) ve kurumsal sağlık sisteminin ana aktörlerine (doktor ve hemşirelere) yönelik tutumlardır.

Nitekim literatürde kolayda örneklem gruplarıyla ya da spesifik popülasyonlarda yapılan çalışmalarda medeni durumun GETAT tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu raporlanmıştır (Kısaç vd., 2024); buna karşın sağlık alanında eğitim gören öğrenciler üzerinde yapılan çalışmalarda bu tür demografik faktörlerin anlamlı bir farklılık yaratmadığı ortaya koyulmuştur (İçer ve Daşlı, 2024). Bu farklılıklar, örneklem gruplarının (sağlık öğrencileri vs. genel erişkinler) farklı sosyolojik özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Ancak Türkiye genel nüfusunu temsil eden katmanlı makro veri setimiz üzerinde yürütülen Lojistik Regresyon modelinde, kurumsal güven ve algılanan gelir gibi güçlü sosyo-ekonomik değişkenler kontrol altına alındığında, söz konusu demografik kırılımların şifacılara güven algısı üzerindeki açıklayıcılık gücünü yitirerek anlamsızlaşması yöntemsel açıdan dikkat çekicidir. Bu durum, genel kamuoyundaki güven örüntülerinin, dar kitlelere uygulanan psikometrik ölçek skorlarından çok daha bütünleşik ve kurumsal bir zeminde şekillendiğini kanıtlamaktadır.

5.3 Güven Algısının Boyutsal ve Geometrik Yapısı

Çoklu Uyum Analizi (MCA) düzleminde elde edilen geometrik yerleşimler, salt istatistiksel birer çıktı olmanın ötesinde, Türkiye'deki sağlık inanç sosyolojisine dair iki büyük kuramsal çıkarım sunmaktadır. Bu çıkarımların temeli, Düzeltilmiş Burt Matrisi haritasında (Şekil 4.5) ortaya çıkan iki boyutun temsil ettiği anlamlar üzerinden şekillenmektedir.

Haritada en yüksek varyansı açıklayan yatay eksen (Boyut 1) incelendiğinde, bu boyutun temel olarak bir "Sosyo-Ekonomik ve Kurumsal Entegrasyon" eksenini olduğu görülmektedir. Eksenin bir kutbunda yüksek gelir düzeyi ile doktor, hemşire ve şifacılara yönelik yüksek güven kategorileri bir arada kümelenmektedir. Bu durum,

Türkiye'de sağlık hizmetlerine yönelik genel güven inancının arkasındaki en büyük ayrıştırıcı gücün, bireylerin ekonomik imkanları ve kurumsal sağlık sistemine olan entegrasyon düzeyleri olduğunu doğrulamaktadır.

İkinci kuramsal çıkarım ise ikincil varyansı açıklayan dikey eksen (Boyut 2) üzerinden okunmaktadır ve bu boyut toplumdaki ortak bir şüphecilik ekseninin varlığına işaret etmektedir. Şekil 4.5'teki iki boyutlu dağılım haritası yakından incelendiğinde, şifacılara yönelik güvenmeyen/mesafeli duran kategorilerin, doktor ve hemşirelere güvenmeme ile aşılarla yönelik olumsuz tutum değişkenleriyle dikey eksen boyunca birlikte kutuplaştığı görülmektedir. Bu durum, Türkiye'de şifacılara güvenmeyen bireylerin bunu kurumsal tıbbı duydukları sarsılmaz bir sadakatten ötürü yapmadıklarını ortaya koymaktadır. Aksine bu grubun şifacıya, aşıya, doktor ve hemşirelere mesafeli duran bütünleşik bir şüphecilik ekseninde şekillendiği anlaşılmaktadır.

Son olarak, Şekil 4.6'da yer alan katılımcı kümelerinin dağılımı ve güven elipsleri, araştırmanın kuramsal altyapısı adına güçlü bir kanıt sunmaktadır. Şifacılara yönelik "yüksek", "sınırlı" ve "düşük" güven gruplarına ait %95 güven elipslerinin koordinat uzayında birbirini kesmeden, tamamen bağımsız ve net sınırlar çizerek konumlanması bu tutumların tesadüfi olmadığını göstermektedir. Bu net geometrik ayırım, katılımcıların şifacılara duydukları güven seviyesinin sadece soyut bir düşünce olmadığını, aksine bireyleri istatistiksel olarak birbirinden tamamen farklı kümelere ayırarak koordinat uzayında belirgin varyans ayrıştırıcıları olarak rol oynadığını kanıtlamaktadır.

5.4 Modellerin Yöntemsel Geçerliliği ve Genel Değerlendirme

Çalışmada Standart MCA yönteminin yapay atalet şişirme sınırlılığını aşmak adına Düzeltilmiş Burt Matrisi yönteminin tercih edilmesi, tezin istatistiksel gücünü en üst seviyeye çıkarmıştır. Nitekim Standart MCA ilk iki boyutta varyansın sadece %21,9'unu açıklayabilirken, Düzeltilmiş Burt Matrisi %88,0 gibi oldukça yüksek ve güçlü bir kümülatif açıklama oranına ulaşmıştır. Bu durum, iki boyutlu faktöriyel harita üzerinde yapılan tüm mekansal yorumların matematiksel olarak yüksek düzeyde güvenilir ve geçerli olduğunu tescillemiştir.

Benzer şekilde, kurulan Çok Terimli Lojistik Regresyon modelinin bir bütün olarak yüksek düzeyde anlamlı çıkması ($X^2 = 91,861$; $p < 0,001$) ve %61,6'lık genel doğru sınıflandırma başarısı yakalaması, elde edilen olasılık katsayılarının veri setinin gerçekliğiyle uyumlu olduğunu doğrulamaktadır. Bununla birlikte, örneklemdaki grup frekanslarının heterojen (asimetrik) dağılımı sebebiyle modelin "düşük güven" kategorisindeki doğru tahmin başarısının sınırlı kalması, çalışmanın yöntemsel bir kısıtlılığı olarak not edilmelidir.

Sonuç olarak; Türkiye’de geleneksel ve tamamlayıcı tıp şifacılarına yönelik güven, sosyo-demografik unsurlardan ziyade, bireylerin resmi sağlık sistemine (doktor ve hemşirelere) duydukları güven inancıyla paralel ve entegre bir şekilde, yüksek gelir kırımının sağladığı tüketim imkanlarıyla şekillenmektedir.

5.5 Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler

- I. **Karma Metodoloji Kullanımı:** Bu tez çalışmasında nicel veri seti üzerinden makro düzeyde saptanan "doktor güveni ile şifacı güveni arasındaki pozitif yönlü entegrasyon" ilişkisinin derinlemesine incelenebilmesi için, gelecek çalışmalarda nitel yöntemlerin de modele dahil edildiği karma metodolojiler kullanılmalıdır.
- II. **GETAT Alt Branşlarının Ayrıştırılması:** Mevcut veri setinde şifacı kavramı genel bir çatı değişken olarak yer almaktadır. Gelecek araştırmalarda akupunktur, fitoterapi, sülük veya hacamat gibi Sağlık Bakanlığı tarafından da tanınan GETAT uygulamaları tek tek ayrıştırılarak, her bir branşa yönelik güven haritaları ayrı ayrı Çoklu Uyum Analizi ile modellenmelidir.
- III. **Zaman Serisi ve Boylamsal Analizler:** Türkiye’de yasal mevzuatın değişimi ve kurumsal tıp eğitimine bu pratiklerin entegre edilme süreci dikkate alınarak, güven algısının yıllar içindeki değişim seyrini saptayacak boylamsal istatistiksel analizler yürütülmelidir.

KAYNAKÇA

- Agresti, A. (2013). *Categorical data analysis* (3. bs.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Akşahin Doğan, B., Özyazgan Tokay, A. A., Boz, G., Oktay, B., Sülü, M. ve Baran, A. (2024). Sağlık müdürlüğünde çalışan personellerin geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp konusunda bilgi ve davranışlarının incelenmesi: Kesitsel araştırma. *Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi*, 7(2), 189-195. <https://doi.org/10.5336/jtracom.2023-101067>
- Cirhinlioğlu, Z. (2010). *Sağlık sosyolojisi*. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Cockerham, W. C. (2016). *Medical sociology* (13. bs.). New York, NY: Routledge.
- Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Greenacre, M. (2007). *Correspondence analysis in practice* (2. bs.). Boca Raton, FL: Chapman and Hall/CRC.
- Hacılar, E., Okka, B., Şahin, T. K. ve Demir, G. S. (2024). 18 yaş üstü bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri hakkında tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi: Kesitsel bir araştırma. *Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi*, 7(1), 66-75. <https://doi.org/10.5336/jtracom.2023-98622>
- Hosmer, D. W. ve Lemeshow, S. (2013). *Applied logistic regression* (3. bs.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- İçer, B. ve Daşlı, Y. (2024). Öğrencilerin alternatif ve geleneksel tıba ilişkin tutum ve davranışlarının belirlenmesine yönelik nicel bir araştırma. *Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi*, 7(9), 705-718. <https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1437>
- İkioşık, H., Kutay Yılmaz, F., Baltalı, O., Direk, Ş., Yayıcı, S., Tahmazoğlu, E., Bayraktar, M., Gençtürk, Ö. ve Maral, I. (2021). Araştırma görevlisi hekimlerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları konusunda düşünce, tutum ve davranışları. *Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi*, 4(2), 246-255. <https://doi.org/10.5336/jtracom.2021-82719>
- Kasapoğlu, A. (1999). *Sağlık sosyolojisi*. Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları.

- Kıskaç, N., Kıskaç, M., Zorlu, M., Karatoprak, C. ve Çakırca, M. (2024). Erişkin bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp tutumlarının değerlendirilmesi. *MAS Journal of Applied Sciences*, 9(1), 127-134.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682614>
- Oral, B., Öztürk, A., Balcı, E. ve Sevinç, N. (2016). Aile sağlığı merkezine başvuranların geleneksel/alternatif tıpla ilgili görüşleri ve kullanım durumu. *TAF Preventive Medicine Bulletin*, 15(2), 75-82.
<https://doi.org/10.5455/pmb.1-1439552842>
- T.C. Sağlık Bakanlığı. (2014, 27 Ekim). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği. *Resmî Gazete*, (Sayı: 29158).
<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141027-3.htm> (Erişim Tarihi: 11.06.2026).
- Turner, B. S. (1995). *Medical power and social knowledge* (2. bs.). London: Sage Publications.
- Wellcome Trust. (2019). *Wellcome Global Monitor 2018: How does the world feel about science and health?* Wellcome Trust.
<https://wellcome.org/insights/reports/wellcome-global-monitor/2018> (Erişim Tarihi: 11.06.2026).
- Wellcome Trust, The Gallup Organization Ltd. (2019). *Wellcome Global Monitor, 2018* [data collection]. 2nd Edition. UK Data Service. SN: 8466,
<https://doi.org/10.5255/UKDA-SN-8466-2> (Erişim Tarihi: 11.06.2026).
- World Health Organization. (2013). *WHO traditional medicine strategy: 2014-2023*. World Health Organization.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241506090> (Erişim Tarihi: 11.06.2026).